

COLEÇÃO
Enfrentamento de doenças
crônicas não transmissíveis no
Sistema Único de Saúde:
**ESTRATÉGIAS PARA
PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

**Atividade física e práticas
corporais na Atenção
Primária à Saúde para as
pessoas com doenças
crônicas não transmissíveis**



RENOB-MG

Rede para Enfrentamento da Obesidade e
Doenças Crônicas em Minas Gerais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável
Av Peter Henry Rolfs, s/n – Campus Universitário
Viçosa – MG CEP: 36570-900
Site: <http://www.ippds.ufv.br/>
E-mail: renob@ufv.br

A coleção **Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para profissionais de saúde** pode ser acessada, na íntegra, no site do RENOB-MG (www.renobmg.ufv.br) e do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (www.ippds.ufv.br).

ORGANIZAÇÃO

Helen Hermana Miranda Hermsdorff
Miguel Araujo Carneiro Junior
Ruama da Silva Lima

ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO

Ana Claudia Pelissari Kravchychyn
Helen Hermana Miranda Hermsdorff
Miguel Araujo Carneiro Júnior
Ruama da Silva Lima

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Editora Asa Pequena

FOTO DA CAPA

Rodrigo Carvalho

REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL

Edir Barbosa

Ficha catalográfica elaborada pela Seção de Catalogação e
Classificação da Biblioteca Central da Universidade Federal de Viçosa

A872
2022 Atividade física e práticas corporais na atenção primária saúde para pessoas com doenças crônicas não transmissíveis [recurso eletrônico] / Helen Hermana Miranda Hermsdorff, Miguel Araujo Carneiro Júnior, Ruama da Silva Lima, organizadores ; Ana Claudia Pelissari Kravchychyn ... [et al.] elaboração de conteúdo – Viçosa, MG: IPPDS, UFRV, 2022. 1 livro eletrônico (82 f.) : il. color. – (Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: Estratégias para profissionais de saúde ; n. 5).

Disponível em: <https://www.renobmg.ufv.br/repositoriocientifico/>.
ISBN 978-65-00-56137-1

1. Exercícios físicos. 2. Manipulações musculoesqueléticas. 3. Saúde pública. 4. Doenças crônicas. I. Hermsdorff, Helen Hermana Miranda, 1979-. II. Carneiro Júnior, Miguel Araujo, 1983-. III. Lima, Ruama da Silva. IV. Kravchychyn, Ana Claudia Pelissari, 1988-. V. Rede para o Enfrentamento da Obesidade em Minas Gerais. VI. Universidade Federal de Viçosa. Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável.

CDD 22. ed. 613.71

Bibliotecária responsável: Bruna Silva CRB6/2552



Este trabalho é disponibilizado nos termos da Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). É permitido o download e o compartilhamento, desde que citada a fonte; não é permitida nenhuma alteração ou utilização para fins comerciais.

AGRADECIMENTOS

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, pelo apoio à realização da formação de Gestores e Profissionais de Saúde para o cuidado de indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis no âmbito da Atenção Primária, possibilitando o aprimoramento desse cuidado.

Ainda, aos Gestores e Profissionais que participam dos cursos Salus para sua qualificação, visando à melhoria da qualidade da atenção ofertada nos respectivos municípios.

Esta coleção foi produzida mediante o apoio da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde juntamente com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MS/SAS/DAB/CGAN nº 421098/2018-0, do CNPq/MS/SAPS/DEPROS nº 442317/2020-4) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES – Ministério da Educação – Código 001).

PREFÁCIO

O Brasil, nas últimas décadas, tem vivenciado um avanço muito rápido no número de pessoas com excesso de peso ou obesidade, além de outras doenças crônicas, como dislipidemias, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. A Atenção Primária à Saúde (APS) é um espaço fundamental para a prevenção e o cuidado integral de pessoas nessa condição de saúde.

Desse modo, quando ampliamos a capacidade de gestão dos estados e dos municípios, bem como a organização no processo de trabalho, os resultados relativos ao manejo dessas doenças no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) são mais efetivos.

Nesse contexto, o Projeto **Rede para enfrentamento da obesidade e doenças crônicas em Minas Gerais (RENOB-MG)** tem como objetivo propiciar a construção de uma rede organizada e qualificada para a atenção à saúde, bem como a excelência em gestão para o gerenciamento dessas condições no estado mineiro a partir de ações de diagnóstico, formação, gestão, avaliação e monitoramento, incluindo atividades de pesquisa, ensino e extensão.

Para tanto, nossa equipe elaborou duas coleções de livros digitais – “Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para gestores de saúde” e “Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para profissionais de saúde”. O objetivo desses livros é capacitar, consolidar e enriquecer o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde e gestores da APS no cuidado da obesidade e no cuidado integral da pessoa que vive com essa e outras doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial sistêmica.

Desejo que o conteúdo apresentado nesta coleção voltada para profissionais da saúde permita a eles o aprimoramento de seus conhecimentos e habilidades que os auxiliarão no manejo da obesidade e de doenças crônicas, de maneira mais humanizada e resolutiva.

Boa leitura!

Helen Hermana Miranda Hermsdorff
Coordenadora do RENOB-MG

APRESENTAÇÃO

Boas-vindas aos leitores do nosso livro digital sobre **Atividade física e práticas corporais na atenção primária à saúde para as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis**, que faz parte da coleção “Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para profissionais de saúde”.

A abordagem em grupo nesta obra digital sobre o tratamento das doenças crônicas pelo SUS permite o compartilhamento de experiências com uma escuta ativa das necessidades dos indivíduos. Dessa forma, os profissionais e participantes buscam soluções em conjunto, visando transformar o conhecimento em atitude. Portanto, os grupos constituem espaços estratégicos para auxiliarem no controle das doenças crônicas, sendo fundamental que os profissionais compreendam a sua importância e incentivem a sua implementação.

Este livro digital aborda, ainda, as Práticas Integrativas e Complementares, que são recursos terapêuticos que buscam a redução do risco de doenças e a recuperação da saúde, a partir do foco em uma escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.

Por fim, as tecnologias de informação e comunicação aplicadas à área da saúde, suas modalidades e possibilidades de utilização para o manejo das doenças crônicas são abordadas nesta obra. A utilização de ferramentas tecnológicas tem por objetivo facilitar a comunicação e o alcance de um alvo em comum.

Boa leitura!

Os autores

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1

A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	13
1. Aspectos legais.....	13
2. Equipe multiprofissional e o profissional de Educação Física na APS	17
3. Programa Previne Brasil	20
4. Programa Academia da Saúde	23
5. Programa Saúde na Escola.....	27
6. Atividade física e atuação interprofissional na APS	30
7. Oportunidades para gestores no âmbito da promoção da atividade física na APS	31
REFERÊNCIAS	33

CAPÍTULO 2

AUMENTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E DIMINUIÇÃO DO COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO NA APS	38
1. Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente	42
1.1. Como pensar a atividade física e quais as recomendações dessa prática para crianças e adolescentes	45
2. Atenção à Saúde do Adulto.....	48
2.1. O contexto atual da vida adulta	48
3. Atenção à Saúde da Pessoa Idosa	50
3.1. O Contexto Social da Pessoa Idosa.....	50
4. Atenção à Pessoa com Obesidade	52
4.1. O contexto da obesidade	52
4.2. Sugestão de cuidados físicos a serem feitos pelo PEF para o melhor acompanhamento da pessoa com sobrepeso e obesidade	55
5. Atenção à Pessoa com Hipertensão Arterial Sistêmica	56
5.1. O contexto da Hipertensão Arterial Sistêmica	56
6. Atenção à Pessoa com Diabetes Mellitus	59
6.1. O contexto do Diabetes Mellitus.....	59
REFERÊNCIAS	62

CAPÍTULO 3.....	65
COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA APS: CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES	65
1. Conhecimentos	68
1.1. Conhecimento conceitual	68
1.2. Conhecimento procedimental.....	68
1.3. Conhecimento contextual	69
2. Habilidades	70
3. Atitudes/Prática	72
REFERÊNCIAS	73
CAPÍTULO 4	
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE PRÁTICAS DE ATIVIDADE FÍSICA NA APS.....	74
1. Definição da “Prática Exitosa”	74
2. Expectativa versus evidências/cotidiano	76
3. Na prática: experiências de sucesso	77
REFERÊNCIAS	80

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Fatores determinantes e condicionantes da saúde.	16
Figura 2: Pontos a serem considerados na atuação do PEF na APS	18
Figura 3: Testes e avaliações físicas que podem ser aplicados pelo PEF para fundamentar a prescrição de exercícios físicos.	19
Figura 4: Critérios do Previne Brasil.....	20
Figura 5: Componentes da capitação ponderada.	21
Figura 6: Programas, estratégias e ações contemplados pelo incentivo para ações estratégicas.....	23
Figura 7: Atividades relacionadas às práticas corporais e atividade física no PAS.	26
Figura 8: Eixos de ações do PAS.	27
Figura 9: Temáticas importantes da atividade física e da saúde.....	31
Figura 10: Vertentes do estímulo à atividade física a serem trabalhadas pelos PEFs na APS...41	
Figura 11: Ações diárias que podem reduzir o comportamento sedentário.	42
Figura 12: O contexto do estímulo à atividade física na infância e na adolescência.	44
Figura 13: Exemplos de atividades conforme a forma de condução dos estímulos de atividade física na infância.....	46
Figura 14: Aspectos importantes para a qualidade de vida e a saúde na fase adulta.	48
Figura 15: Benefícios da atividade física regular para a terceira idade.....	51
Figura 16: Benefícios da prática regular de atividade física para pessoas com sobrepeso e obesidade.	54
Figura 17: Aspectos importantes a serem acompanhados antes e durante a atividade física de pessoas com sobrepeso e obesidade.....	56
Figura 18: Fatores de risco modificáveis e não modificáveis para o desenvolvimento da HAS... 57	
Figura 19: Tratamento não farmacológico para HAS sugerido pelas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial	57
Figura 20: Benefícios do exercício físico para pacientes com DM.	60
Figura 21: Cuidados a serem tomados no monitoramento da atividade física de pessoas com Diabetes Mellitus.	62
Figura 22: Organograma das dimensões das competências do PEF na APS e seus indicadores.	68
Figura 23: Estratégias essenciais para tornar uma prática de atividade física exitosa.....	75
Figura 24: Práticas corporais/atividade física desenvolvidas na Academia de Saúde Balneário Piçarras.	78

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Inatividade física X Comportamento sedentário	13
Quadro 2: Ações relacionadas às práticas corporais/atividade física priorizadas pela PNPS	15
Quadro 3: Principais significados/benefícios do código permanente da CBO para os PEFs.	17
Quadro 4: Indicadores Previne Brasil para o ano 2022	22
Quadro 5: Programas que antecederam e inspiraram a criação do PAS	24
Quadro 6: Diretrizes, princípios e objetivos do PAS.....	25
Quadro 7: Diretrizes e objetivos do PSE	28
Quadro 8: Sugestões de ações relacionadas a práticas corporais/atividade física no âmbito escolar	30
Quadro 9: Etapas para a construção de novos polos do PAS	32
Quadro 10: Temas importantes a serem abordados no contexto da atividade física para qualquer faixa etária.....	42
Quadro 11: Problemas médicos gerados pelo uso excessivo de tecnologias na infância.....	45
Quadro 12: Atividades e tempo de prática indicados por faixa etária infantil e de adolescente	47
Quadro 13: Diferenças no perfil de trabalho após o desenvolvimento tecnológico	49
Quadro 14: Atividades e tempo de prática indicados para adultos com base no Guia de Atividade Física para a População Brasileira	50
Quadro 15: Atividades e tempo de prática indicados para a pessoa idosa, com base no Guia de Atividade Física para a População Brasileira	52
Quadro 16: Atividades e tempo de prática indicados para pessoas com sobrepeso e obesidade	55
Quadro 17: Atividades e tempo de prática indicados para pessoas com HAS.....	58
Quadro 18: Classificações do Diabetes Mellitus	59
Quadro 19: Fatores de risco para o desenvolvimento de DM2	60
Quadro 20: Atividades e tempo de prática indicados para pessoas com diabetes	61
Quadro 21: Diferenças de abordagem do indivíduo na APS entre o Modelo Tradicional e o Modelo de Apoio Matricial.....	66
Quadro 22: Conhecimentos conceituais para o PEF que atua na APS.....	69
Quadro 23: Conhecimentos procedimentais para o PEF que atua na APS.....	69
Quadro 24: Conhecimentos contextuais para o PEF que atua na APS	70
Quadro 25: Dimensões das habilidades com suas especificidades nos nichos de: Planejamento, Comunicação, Avaliação, Incentivação e Gestão	71
Quadro 26: Atitudes que auxiliam e norteiam o trabalho do PEF na APS	73
Quadro 27: Atributos das práticas exitosas em atividade física na APS	75
Quadro 28: Programas de atividades físicas analisados	76
Quadro 29: Orientações PNPS x Realidade prática	77
Quadro 30: Setores envolvidos no Projeto Blumenau + Leve e suas correspondentes ações relativas às práticas corporais/atividade física	79

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

APS	Atenção Primária à Saúde
CBO	Classificação Brasileira de Ocupações
CIT	Comissão Intergestores Tripartite
CNS	Conselho Nacional de Saúde
DM	Diabetes Mellitus
DM1	Diabetes Mellitus tipo I
DM2	Diabetes Mellitus tipo II
DCV	Doenças Cardiovasculares
DCNT	Doenças Crônicas Não Transmissíveis
ESF	Estratégia Saúde da Família
FNS	Fundo Nacional de Saúde
HAS	Hipertensão Arterial Sistêmica
NASF-AB	Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica
NASFs	Núcleos de Apoio à Saúde da Família
PNPS	Política Nacional de Promoção da Saúde
PAD	Pressão Arterial Diastólica
PAS	Pressão Arterial Sistólica
PEFs	Profissionais de Educação Física
PAS	Programa Academia da Saúde
PSF	Programa Saúde da Família
PSE	Programa Saúde na Escola
PEC	Prontuário Eletrônico do Cidadão
SISMOB	Sistema de Monitoramento de Obras
SUS	Sistema Único de Saúde
SIOP	Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
UBS	Unidade Básica de Saúde



CAPÍTULO 1

A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Ruama da Silva Lima, Helen Hermana Miranda Hermsdorff, Miguel Araújo Carneiro Júnior

1. Aspectos legais

númeras evidências comprovam a importância da prática regular de atividade física na prevenção e controle das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), na diminuição dos sintomas de depressão e ansiedade e no aumento do bem-estar geral, entre outros benefícios (WHO, 2020). Em contrapartida, tanto a inatividade física quanto o comportamento sedentário estão associados a efeitos deletérios para a saúde (MENEGUCI et al., 2015), apesar de apresentarem conceitos diferentes (Quadro 1).

Quadro 1: Inatividade física X Comportamento sedentário

Inatividade física	Comportamento sedentário
Quando o volume de atividade física em intensidades adequadas é menor do que o recomendado.	Atividades de pouca movimentação durante o período da pessoa acordada com o corpo na posição sentada ou reclinada e com gasto energético similar ao observado no estado de repouso.

Fonte: Adaptado de Mielke e Garcia, 2014; Guerra, de Farias Júnior e Florindo, 2016.

Nesse contexto, a promoção da atividade física tem sido cada vez mais evidenciada em sistemas públicos de saúde em todo o mundo (BECKER; GONÇALVES; REIS, 2016). No cenário brasileiro, a própria criação e instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988 já constituem marco importante para esta realidade, pois a concepção de saúde, antes entendida como o “estado de não doença”, passou a dar lugar a uma abordagem mais ampla, centrando-se, inclusive, na prevenção de agravos e na promoção da saúde (BRASIL, 2000).

**SAIBA MAIS!**

Para obter mais informações sobre o SUS brasileiro, acesse aqui o material do Ministério da Saúde **SUS – princípios e conquistas**.



Com a publicação da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 218, de 06 de março de 1997, Profissionais de Educação Física (PEF) passaram a ser reconhecidos como profissionais de saúde (BRASIL, 1997). Posteriormente, a Resolução do CONFEF nº 046, de 18 de fevereiro de 2002, ressalta, mais uma vez, o campo da saúde como possível área de atuação do PEF (CONFEF, 2002).

**SAIBA MAIS!**

Para conhecer na íntegra as Resoluções que regulamentam a atuação dos PEFs, clique nas imagens. A primeira, a **Resolução nº 218, de 06 de março DE 1997**; e a segunda, a **Resolução CONFEF nº 046/2002**.



Diante do exposto, um importante passo que de fato efetivou a atuação desses profissionais nesta área, em especial no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), foi a aprovação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), que apresentou como uma de suas áreas temáticas as práticas corporais/atividade física como fator de proteção para a saúde (MALTA et al., 2009). No **Quadro 2** são apresentadas as ações que foram priorizadas pela PNPS, considerando o eixo de práticas corporais/atividade física.

Outra medida que contribuiu significativamente para evidenciar a prática de atividade física na APS foi a criação dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASFs-AB), por meio da Portaria 154/GM, de 2008, na ocasião denominados apenas como Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs) (OLIVEIRA; ROCHA; CUTOLO, 2012). Esses núcleos tiveram como base o fortalecimento da ESF, aumentando, assim, a abrangência e escopo das ações da APS no Brasil (BRASIL, 2010). Em certo ponto, os NASFs-AB tornaram-se a principal porta de entrada para os PEFs atuarem no contexto da APS (LOCH; DIAS; RECH, 2019).

Quadro 2: Ações relacionadas às práticas corporais/atividade física priorizadas pela PNPS

Ação na Rede Básica de Saúde e na comunidade
Mapear e apoiar as ações de práticas corporais/atividade física existentes nos serviços de APS e na Estratégia Saúde da Família (ESF) e inseri-las naqueles em que não há tais ações.
Oferecer nas redes básicas de saúde práticas corporais/atividade física, como caminhadas, prescrição de exercícios, práticas lúdicas, esportivas e de lazer, voltadas tanto para a comunidade como um todo quanto para grupos vulneráveis.
Capacitar os trabalhadores de saúde em conteúdos de promoção à saúde e práticas corporais/atividade física na lógica da educação permanente, incluindo a avaliação como parte do processo.
Estimular a inclusão de pessoas com deficiências em projetos de práticas corporais/atividade física.
Pactuar com os gestores do SUS e de outros setores nos três níveis de gestão a importância de ações voltadas para melhorias ambientais, com o objetivo de aumentar os níveis de atividade física da população.
Construir mecanismos de sustentabilidade e continuidade das ações do “Pratique Saúde no SUS” (equipamentos e área física adequados, equipe capacitada, em articulação com a rede de atenção).
Incentivar articulações intersetoriais para a melhoria das condições dos espaços públicos para a realização de práticas corporais/atividade física (urbanização dos espaços públicos, criação de ciclovias e pistas de caminhadas, segurança e outros).
Ação de aconselhamento/divulgação
Organizar os serviços de saúde de forma a desenvolver ações de aconselhamento junto à população sobre os benefícios das práticas corporais/atividade física e estilos de vida saudáveis.
Desenvolver campanhas de divulgação, estimulando modos de viver ativos e saudáveis e objetivando reduzir fatores de risco para as DCNT.
Ação de intersetorialidade e mobilização de parceiros
Pactuar com os gestores do SUS e outros setores nos três níveis de gestão a importância de desenvolver ações voltadas para estilos de vida ativos e saudáveis, mobilizando os recursos disponíveis.
Estimular a formação de redes horizontais de troca de experiências entre municípios.
Estimular a inserção e fortalecimento de ações já existentes no campo das práticas corporais em saúde na comunidade.
Resgatar as práticas corporais/atividade física de forma regular nas escolas, nas universidades e nos demais espaços públicos.
Articular parcerias, estimulando práticas corporais/atividade física no ambiente de trabalho.
Ação de monitoramento e avaliação
Desenvolver estudos e formular metodologias capazes de produzir evidências e comprovar a efetividade de estratégias de práticas corporais/atividade física no controle e na prevenção das DCNT.
Estimular a articulação com instituições de ensino e pesquisa para monitoramento e avaliação das ações no campo das práticas corporais/atividade física.
Consolidar a Pesquisa de Saúde dos Escolares (SVC/MS) como forma de monitoramento de práticas corporais/atividade física de adolescentes.

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2010.

**FIQUE LIGADO!**

Depois de terem passado por reformulação, por meio da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2017, os NASFs tiveram a nomenclatura redefinida para NASF-AB (BRASIL, 2017).

Apesar de os NASFs-AB ainda permanecerem presentes em determinados municípios, desde o mês de janeiro de 2020 o Ministério da Saúde não faz mais o credenciamento de novas equipes. Isso porque, de acordo com o novo modelo de financiamento de custeio da APS, instituído pelo Programa Previne Brasil no ano 2019, os gestores municipais ficaram aptos para cadastrarem profissionais diretamente nas ESFs ou nas equipes de Atenção Primária.

**SAIBA MAIS!**

Se quiser saber mais sobre a **Nota Técnica nº 3/2020-DES/SAPS/MS**, que trata do NASF-AB e do Programa Previne Brasil, clique aqui.



Outro marco importante nesse cenário foi a criação da Lei nº 12.864, de 24 de setembro de 2013, que alterou o Caput do art. 3º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluindo, assim, a atividade física como fator determinante e condicionante da saúde (BRASIL, 2013). A **Figura 1** ilustra os fatores determinantes e condicionantes da saúde de acordo com essas Leis.

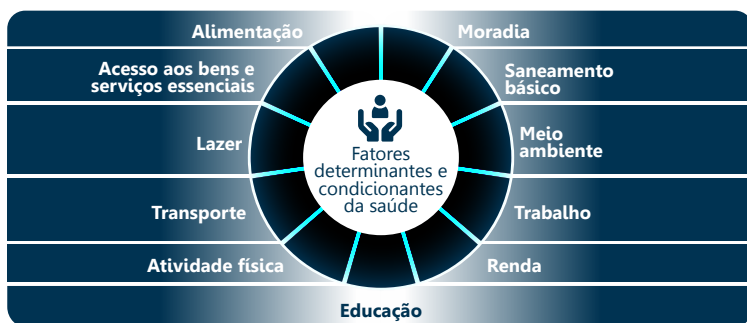


Figura 1: Fatores determinantes e condicionantes da saúde.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2013.

Por fim, vale ressaltar que, no início do ano 2020, os PEFs foram reconhecidos permanentemente pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob o Código Permanente 2241-40, como “Profissional de Educação Física na Saúde” (CONFEEF, 2020). No **Quadro 3** são apresentados os principais significados/benefícios do código permanente da CBO.

Quadro 3: Principais significados/benefícios do código permanente da CBO para os PEFs

Favorece a contratação de PEFs pelos setores público e privado de saúde.

Consolida o PEF como integrante de equipe de saúde.

Reforça a inserção do PEF na saúde.

Fortalece a participação do PEF no SUS.

Define atividades de competência do PEF no Setor de Saúde.

Fonte: Adaptado do Conselho Federal de Educação Física – CONFEEF, 2020.

2. Equipe multiprofissional e o profissional de Educação Física na APS

A APS deve ser considerada a porta de entrada do SUS. Desde 1994, com a implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) na APS, atualmente denominado ESF, a família passou a ser concebida como unidade de intervenção, devendo as práticas profissionais favorecer a promoção, prevenção e recuperação da saúde dessa unidade (DOS SANTOS, 2018; FAUSTO et al., 2018; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010).



FIQUE LIGADO!

Um ponto importante a ser destacado com a implementação da ESF é o estabelecimento de equipes multiprofissionais, que são compostas minimamente por Médico Generalista, ou Especialista em Saúde da Família ou Médico de Família e Comunidade, Enfermeiro Generalista ou Especialista em Saúde da Família, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (BRASIL, 2012).

Atualmente, visando aumentar a abrangência das ações desenvolvidas na APS, os gestores municipais têm autonomia para definir e cadastrar outros profissionais diretamente nas equipes de Saúde da Família ou nas equipes de Atenção Primária, ampliando, assim, sua composição mínima (BRASIL, 2020). Um dos profissionais aptos a comporem as equipes multiprofissionais é o PEF (DA SILVA et al., 2022). A atu-

ação do PEF abrange ações direcionadas às práticas corporais/atividade física como forma de contribuir para a promoção da saúde (BRASIL, 2010). Assim, é importante que o planejamento das intervenções priorize não somente o aspecto fisiológico, mas que contemple também as dimensões psicológica e sociológica, valorizando, inclusive, a diversidade de manifestações da cultura corporal presentes tanto localmente quanto as que são difundidas nacionalmente (BRASIL, 2010). Na **Figura 2** são apresentados alguns pontos importantes relacionados à atuação do PEF na APS.

- 1 Buscar atuação coerente com os princípios e diretrizes do SUS
- 2 Estar comprometido com a qualidade do serviço
- 3 Buscar um bom conhecimento do território
- 4 Participar do planejamento das ações de saúde da APS
- 5 Buscar estimular e fomentar a participação e controle social
- 6 Buscar organizar e participar de atividades de educação em saúde, considerando a cultura dos sujeitos e das comunidades e buscando estabelecer uma relação que respeite esses saberes
- 7 Participar de atividades de apoio matricial
- 8 Reconhecer os múltiplos determinantes da atividade física (e de outros comportamentos relacionados à saúde), evitando uma abordagem moralista e que considere o estilo de vida apenas consequência das escolhas individuais de cada sujeito
- 9 Reconhecer a atividade física como objeto complexo e que a orientação para a prática de atividade física não é exclusiva de uma única profissão
- 10 Buscar fomentar a atuação intra e intersetorial para a promoção de atividade física
- 11 Não focar a atuação na prescrição individualizada
- 12 A organização de grupos para a prática de atividade física não deve ser a única estratégia de atuação dos PEFs
- 13 Na atuação com os grupos de prática de atividade física, buscar explorar a riqueza de possibilidades das atividades físicas
- 14 Valorizar a utilização de espaços públicos
- 15 Buscar realizar avaliações permanentes

Figura 2: Pontos a serem considerados na atuação do PEF na APS .

Fonte: Adaptado de Loch, Dias e Rech, 2019, p. 2.

Para além das intervenções relacionadas às práticas corporais/atividade física propriamente ditas, é importante que o PEF inclua em sua programação de trabalho a realização de avaliações físicas, visando, assim, reunir elementos para fundamentar a sua decisão relacionada à prescrição dos exercícios (CONFEEF, 2012). Assim, muitos são os protocolos para avaliações e testes disponíveis na literatura (**Figura 3**), entretanto é necessário sempre observar aqueles que possuem aplicação mais adequada e viável, considerando a realidade de cada município (DA SILVA, 2016).

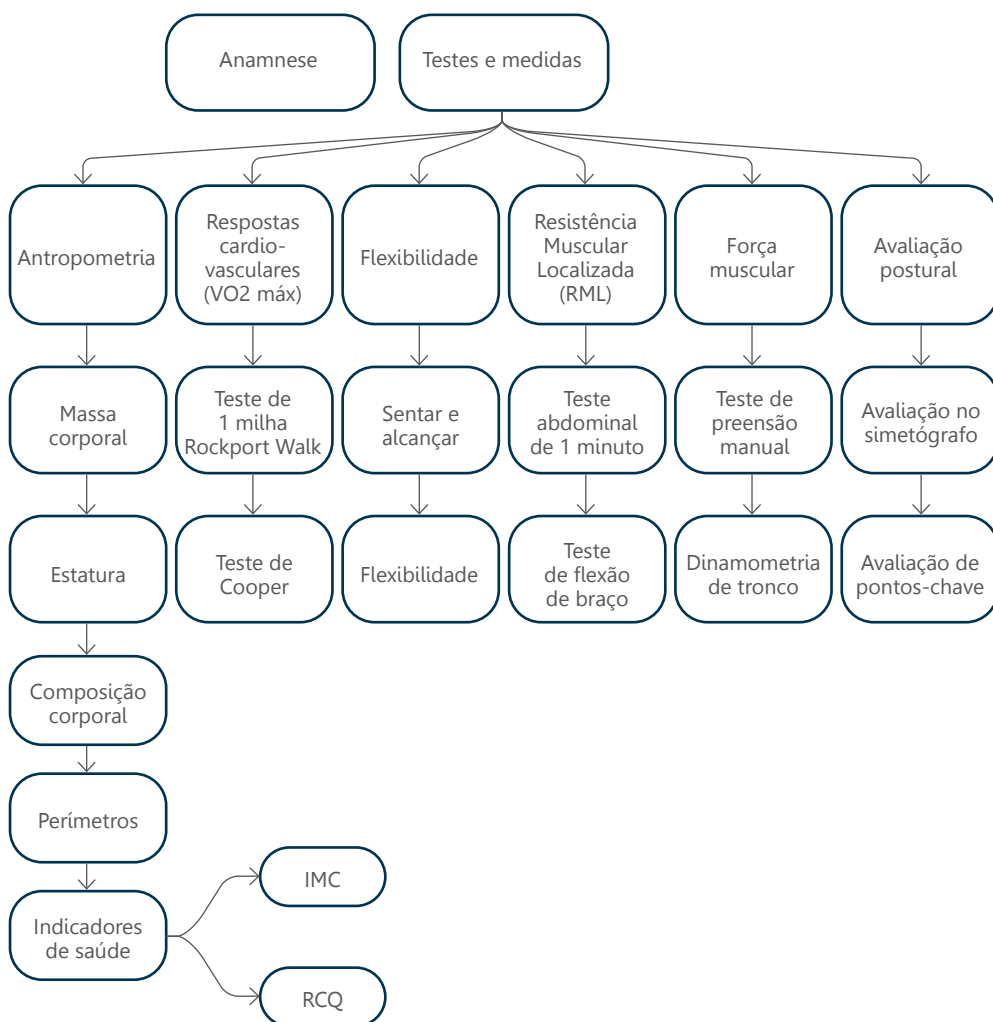


Figura 3: Testes e avaliações físicas que podem ser aplicados pelo PEF para fundamentar a prescrição de exercícios físicos.

Fonte: Adaptado de Silva, 2016, p. 80-132.

**SAIBA MAIS!**

Se deseja obter mais informações sobre os testes e avaliações, acesse aqui o material **Orientações para avaliação e prescrição de exercícios físicos direcionados à saúde**.



Por fim, enquanto membro de uma equipe multiprofissional que atua na APS, cabe ao PEF desenvolver ações que auxiliem na diminuição de danos e agravos decorrentes das DCNT, bem como para a redução do consumo de medicamentos, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população (CONFEE, 2010).

3. Programa Previne Brasil

O Programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, com o objetivo de estabelecer um novo modelo de financiamento de custeio da APS no âmbito do SUS (BRASIL, 2019). Os critérios que constituem esse Programa e dão base para as formas de repasses das transferências para os municípios são apresentados na **Figura 4**.

**Capitação
modeada**

Pagamento por pessoa cadastrada em equipe Saúde da Família e equipe de Atenção Primária. Para definir o valor da transferência financeira, são aplicados pesos sobre a população cadastrada, considerando necessidades de saúde e custos assistenciais, com vistas à garantia da equidade.

**Pagamento por
desempenho**

Pagamento pelos resultados de indicadores alcançados pelos municípios com equipes Saúde da Família e equipes de Atenção Primária, equipes de saúde bucal e equipes multiprofissionais. O conjunto de indicadores é relacionado a áreas estratégicas e publicado em portaria.

**Incentivo
para ações
estratégicas**

Pagamento por equipes, serviços ou programas da APS. Cada equipe, serviço ou programa tem seu regramento específico.

Figura 4: Critérios do Previne Brasil.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2021, p. 7.

Na capitação ponderada, o cadastro das pessoas visa mapear não somente as condições de saúde, mas considerar também a moradia, o saneamento básico da região, os equipamentos sociais disponíveis, entre outros (BRASIL, 2021). É por isso que no cálculo para a definição dos incentivos financeiros da capitação ponderada são considerados alguns componentes (**Figura 5**).

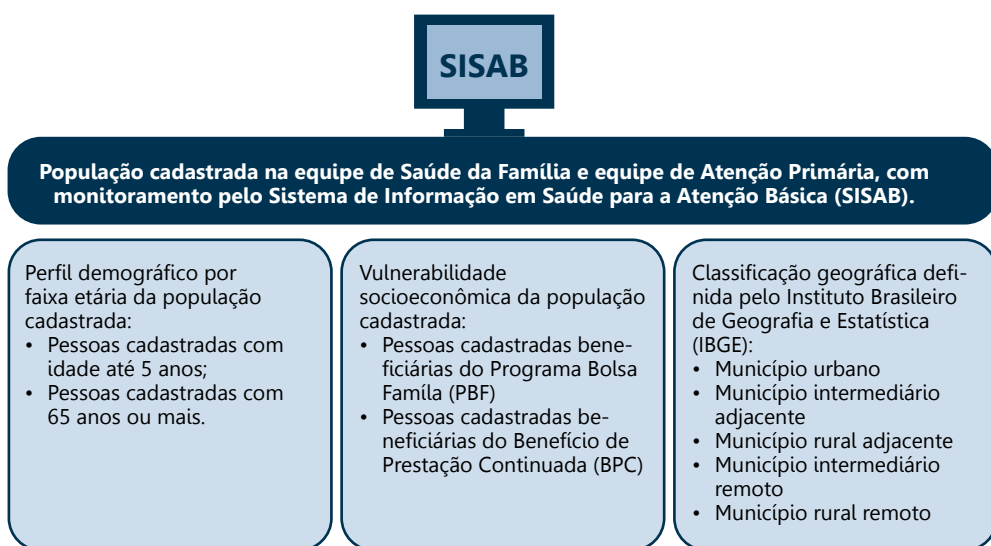


Figura 5: Componentes da capitação ponderada.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2019.

Os cadastros considerados para o cálculo da capitação podem ser de dois tipos (VOTORANTIM, s.d.):

- 1) **Individual:** pode ser feito por todos os profissionais das equipes no momento da ida das pessoas às UBSs ou em visitas domiciliares.
- 2) **Simplificado:** pode ser feito durante o contato com as pessoas nos serviços de Atenção Primária pelos profissionais das equipes nos sistemas de prontuário eletrônico.



FIQUE LIGADO!

Os sistemas utilizados para realizar os cadastros são: sistema E-SUS AB – via Coleta de Dados Simplificados (CDS) ou Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC); ou sistemas de prontuários eletrônicos próprios (VOTORANTIM, s.d.).

Considerando o pagamento por desempenho, a definição do valor a ser transferido depende dos resultados alcançados no conjunto de indicadores monitorados e avaliados no trabalho das equipes de Saúde da Família e Atenção Básica (BRASIL, 2022). No **Quadro 4** são apresentados os indicadores Previne Brasil para o ano 2022, por exemplo.

Quadro 4: Indicadores Previne Brasil para o ano 2022

Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natais realizadas, sendo a 1ª até a 12ª semana de gestação.
Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.
Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.
Proporção de mulheres com coleta de exame citopatológico na APS.
Proporção de crianças de 1 ano de idade vacinadas na APS contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b e poliomielite inativada.
Proporção de pessoas com hipertensão com consulta e pressão arterial aferida no semestre.
Proporção de pessoas com Diabetes Mellitus, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2022.



SAIBA MAIS!

Acesse os sites a seguir, na íntegra, as notas técnicas sobre os **Indicadores Previne Brasil – 2022**:

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

NOTA 4

NOTA 5

NOTA 6

NOTA 7



Assim, o valor do incentivo financeiro para ações estratégicas é definido com base nas necessidades de cada município ou território, de modo a contemplar a efetivação de programas, estratégias e ações que agreguem melhoria ao cuidado na APS (BRASIL, 2022), como mostrado na **Figura 6**.

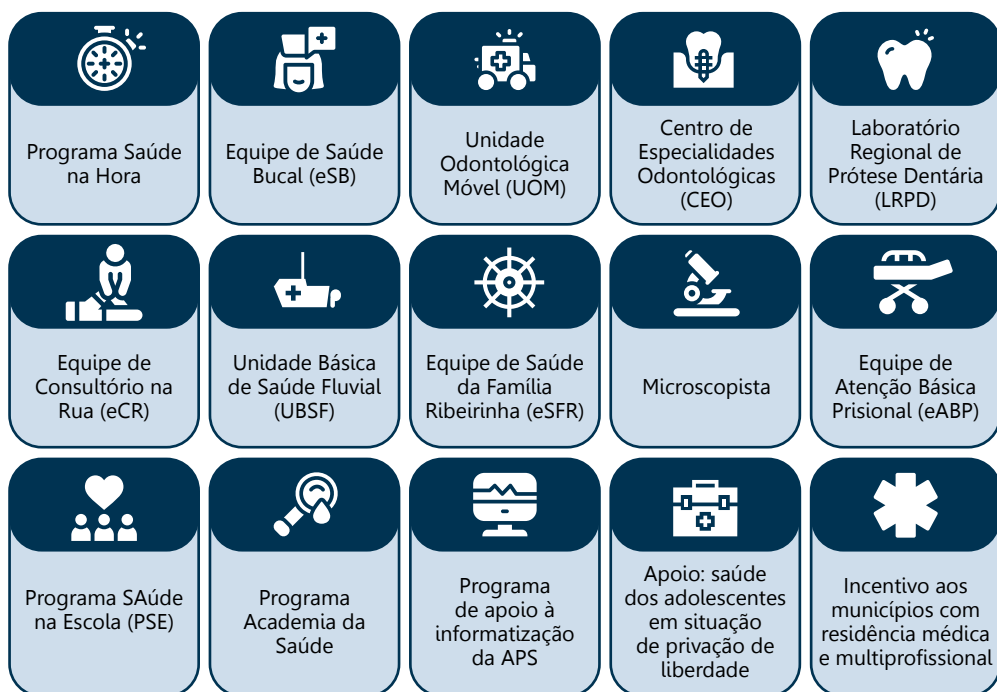


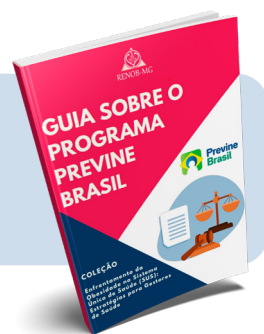
Figura 6: Programas, estratégias e ações contemplados pelo incentivo para ações estratégicas.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2022.



SAIBA MAIS!

Para saber mais sobre o Programa Previne Brasil, clique aqui e baixe o e-book **Guia sobre o Programa Previne Brasil**.



4. Programa Academia da Saúde

O **Programa Academia da Saúde (PAS)** foi criado em 2011 como uma das estratégias de promoção da saúde e produção do cuidado (BRASIL, 2011). No **Quadro 5** são apresentadas algumas experiências de programas que antecederam a implementação do PAS e inspiraram a sua criação.

Quadro 5: Programas que antecederam e inspiraram a criação do PAS

Programa	Cidade	Ano
Programa Academia da Cidade	Belo Horizonte	2005
Programa Academia da Cidade	Aracaju	2003
Programa Academia da Cidade	Recife	2002
CuritibaAtiva	Curitiba	1997
Serviço de Orientação ao Exercício	Vitória	1990

Fonte: Adaptado de Brasil, 2019, p. 68.

**SAIBA MAIS!**

Se quiser obter mais informações sobre os programas descritos no **Quadro 7**, acesse os links clicando nas figuras a seguir:



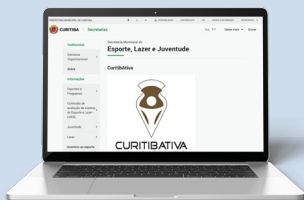
Belo Horizonte



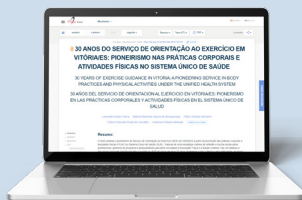
Aracaju



Recife



Curitiba



Vitória

As diretrizes, princípios e objetivos que servem para nortear as ações a serem desenvolvidas no PAS são apresentados no **Quadro 6**.

Os espaços públicos construídos para o desenvolvimento das ações do PAS são chamados de polos, os quais fazem parte da rede de APS e são compostos por infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados (BRASIL, 2019).

Quadro 6: Diretrizes, princípios e objetivos do PAS

Diretriz
Configurar-se como ponto de atenção da Rede de Atenção à Saúde complementar e potencializador das ações de cuidados individuais e coletivos na APS.
Referenciar-se como um programa de promoção da saúde, prevenção e atenção das DCNTs.
Estabelecer-se como espaço de produção, ressignificação e vivência de conhecimentos favoráveis à construção coletiva de modos de vida saudáveis.
Princípio
Participação popular e construção coletiva de saberes e práticas em promoção de saúde.
Intersetorialidade na construção e desenvolvimento das ações.
Interdisciplinaridade na produção do conhecimento e do cuidado.
Integralidade do cuidado.
Intergeracionalidade, promovendo diálogo e troca entre gerações.
Territorialidade, reconhecendo o espaço como local de produção da saúde.
Objetivo
Ampliar o acesso da população às políticas públicas de promoção da saúde.
Fortalecer a promoção de saúde como estratégia de produção da saúde.
Ampliar o acesso da população às políticas públicas de promoção da saúde.
Fortalecer a promoção de saúde como estratégia de produção da saúde.
Desenvolver a atenção à saúde nas linhas de cuidado, a fim de promover o cuidado integral.
Promover práticas de educação em saúde.
Promover ações intersetoriais com outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde e outros equipamentos sociais do território.
Potencializar as ações, nos âmbitos da APS, da vigilância em saúde.
Promover a integração multiprofissional na construção e execução das ações.
Promover a convergência de projetos ou programas nos âmbitos da saúde, educação, cultura, assistência social, esporte e lazer.
Ampliar a autonomia dos indivíduos sobre as escolhas de modos de vida mais saudáveis.
Aumentar o nível de atividade física da população.
Promover hábitos alimentares saudáveis.
Promover mobilização comunitária com a constituição de redes sociais de apoio e ambientes de convivência e solidariedade.
Potencializar as manifestações culturais locais e o conhecimento popular na construção de alternativas individuais e coletivas que favoreçam a promoção da saúde.
Contribuir para a ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de lazer, como proposta de inclusão social, enfrentamento de violências e melhora de saúde e qualidade de vida da população.

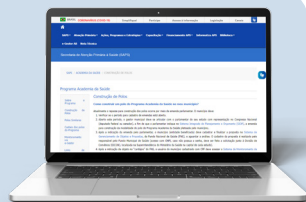
Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017.

**FIQUE LIGADO!**

Os polos do PAS apresentam dois espaços: áreas cobertas e áreas descobertas; além disso, existem três modalidades de polos: modalidade básica, modalidade intermediária e modalidade avançada. O tipo de modalidade varia de acordo com o valor de repasse e o tipo/metragem das estruturas (BRASIL, 2019).

**SAIBA MAIS!**

Para saber mais sobre os procedimentos necessários para a construção de novos polos do PAS, confira as informações disponíveis no site do Ministério da Saúde, clicando aqui.



As atividades do PAS são desenvolvidas por profissionais da APS, podendo haver a inclusão de outros profissionais, a depender das necessidades e objetivos do programa (BRASIL, 2011). A **Figura 7** exemplifica algumas dimensões de atividades que podem ser realizadas no PAS, considerando a promoção de práticas corporais e atividade física.



Figura 7: Atividades relacionadas às práticas corporais e atividade física no PAS.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2011.

Por fim, é válido ressaltar que, apesar do nome do programa, as ações que o compõem não se restringem apenas às práticas corporais/atividade física (BRASIL, 2017). Na **Figura 8** são apresentados os eixos de ações que podem ser desenvolvidas nos polos do PAS.



Figura 8: Eixos de ações do PAS.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2017.

5. Programa Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi criado no ano 2007 e constitui uma política intersetorial da Saúde e da Educação, visando contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos e de atenção à saúde (BRASIL, 2007). As diretrizes e objetivos do PSE são apresentados no **Quadro 7**.



FIQUE LIGADO!

O público contemplado pelo PSE são crianças, adolescentes, jovens e adultos estudantes da educação básica brasileira (BRASIL, 2011).

Quadro 7: Diretrizes e objetivos do PSE

Diretriz
Descentralização e respeito à autonomia federativa.
Integração e articulação das redes públicas de ensino e de saúde.
Territorialidade.
Interdisciplinaridade e intersetorialidade.
Integralidade.
Cuidado ao longo do tempo.
Controle social.
Monitoramento e avaliação permanentes.
Objetivo
Promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação.
Articular as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) às ações das redes de educação básica pública, de forma a ampliar o alcance e impacto de suas ações relativas aos estudantes e às suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis.
Contribuir para a constituição de condições para a formação integral de educandos.
Contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos.
Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar.
Promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos estudantes.
Fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e saúde, nos três níveis de governo.

Fonte: Adaptado de BRASIL, 200+-7.

As ações a serem desenvolvidas na perspectiva do PSE devem buscar contemplar a promoção, prevenção e assistência em saúde (BRASIL, 2009). Algumas dessas possíveis ações são:

- Avaliação clínica.
- Avaliação nutricional.
- Promoção da alimentação saudável.
- Avaliação oftalmológica.
- Avaliação da saúde e da higiene bucal.
- Avaliação auditiva.
- Avaliação psicossocial.
- Atualização e controle do calendário vacinal.
- Redução da morbimortalidade por acidentes e violências.

- Prevenção e redução do consumo de álcool.
- Prevenção do uso de drogas.
- Promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva.
- Controle do tabagismo e de outros fatores de risco de câncer.
- Educação permanente em saúde.
- Atividade física e saúde.
- Promoção da cultura da preservação no âmbito escolar.
- Inclusão de temáticas de educação em saúde no projeto político-pedagógico.

Uma etapa importante a ser considerada dentro das ações relacionadas à atividade física e à saúde é a avaliação pré-participação em esportes, visando, assim, analisar se a criança/adolescente têm condições de participar com segurança de determinada atividade esportiva organizada. Na ocasião da avaliação, também é válido buscar conhecer sobre os significados pessoais que a criança/adolescente atribuem a determinada atividade esportiva, podendo ser identificada, por exemplo, a presença de transtornos alimentares (situações em que a prática de esportes é utilizada como método compensatório para a manutenção do peso) (BRASIL, 2009).



SAIBA MAIS!

Para saber mais sobre transtornos alimentares comuns na adolescência, acesse aqui o material da Sociedade Brasileira de Pediatria.



Além de as práticas corporais/atividade física favorecerem a comunidade escolar sob o aspecto da prevenção e enfrentamento das doenças crônicas, a adesão a essas práticas gera impactos positivos sobre outras esferas das dimensões física, psicológica, social e cultural dos alunos (BRASIL, 2011). Algumas sugestões de ações relacionadas a práticas corporais/atividade física no âmbito escolar são apresentadas no **Quadro 8**.

Quadro 8: Sugestões de ações relacionadas a práticas corporais/atividade física no âmbito escolar

Realizar festivais de jogos esportivos (vôlei, basquete etc.) e populares (peteca, corda, queimada etc.), com a participação dos educandos na construção do evento.

Implantar o “recreio dirigido” nas escolas onde a equipe escolar inclui essa estratégia no planejamento escolar. O objetivo é oferecer simultaneamente atividades orientadas durante o recreio, como minipalestras, jogos, brincadeiras e dança.

Realizar palestras conjuntas com a participação dos alunos, dos pais ou de pessoas de referência sobre a importância da prática de atividade física como componente importante na prevenção de doenças.

Incluir, nas atividades extracurriculares, passeios temáticos, brincadeiras no parque, caminhadas ecológicas etc.

Desenvolver os jogos escolares interclasses ou interescolas como estímulo à prática de esporte, garantido a participação de meninos e meninas – Essa ação deverá constar no planejamento da Secretaria de Educação. Caso o esporte e lazer estejam em outra Secretaria, esta deverá ser acionada para ajudar na elaboração e organização dos jogos. Recomenda-se a participação de alunos representantes na Comissão Organizadora.

Realizar sessões discursivas sobre filmes relacionados ao tema da promoção da saúde, atividade física, esporte e lazer.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2011, p. 38.

**FIQUE LIGADO!**

Profissionais de outros programas também podem apoiar as ações de práticas corporais/atividade física realizadas no PSE. Ex.: Segundo Tempo, Esporte e Lazer da Cidade, Escola Aberta, Academia da Saúde e demais projetos locais de esporte e lazer (BRASIL, 2011).

6. Atividade física e atuação interprofissional na APS

Apesar de o PEF ser o profissional responsável e capacitado para realizar prescrições e orientações relacionadas ao exercício físico, o aconselhamento para a prática de atividade física pode ser realizado por todos os profissionais que atuam na APS (SPERLING, 2017).

**FIQUE LIGADO!**

O aconselhamento para a promoção da atividade física é caracterizado como orientação geral de incentivo direcionada ao usuário do SUS, para que ele inicie ou continue uma prática de atividade física, sobretudo nos domínios do lazer e do deslocamento (FLORINDO; ANDRADE, 2015).

Entre as principais barreiras relacionadas ao aconselhamento para a prática de atividade física, destacam-se: falta de tempo nas consultas; falta de espaço para indicar aonde as pessoas poderiam praticar tais atividades e falta de conhecimento sobre o tema em questão (SPERLING, 2017). Na **Figura 9** são apresentadas algumas temáticas importantes que podem ser discutidas entre profissionais de saúde, de modo a contribuir para o aconselhamento para a prática de atividade física.

- 1 Conceito de atividade física, explicação dos quatro domínios importantes para a promoção da atividade física, as diferenças entre atividade física e exercício físico
- 2 Recomendações para a prática de atividade física para a saúde
- 3 Conceitos de comportamento sedentário, atividades leves, moderadas e vigorosas
- 4 Benefícios da prática de atividade física para a saúde
- 5 Fatores associados e as barreiras para a prática de atividade física
- 6 Atestado médico para a prática de exercícios físicos e esportes
- 7 Resultados positivos para a promoção da atividade física a partir de aconselhamentos de médicos e enfermeiros na atenção básica à saúde e orientações para realizar aconselhamentos para a promoção da atividade física

Figura 9: Temáticas importantes da atividade física e da saúde.

Fonte: Adaptado de Florindo e Andrade, 2015, p. 83.

7. Oportunidades para gestores no âmbito da promoção da atividade física na APS

Inicialmente, quando o Ministério da Saúde começou a financiar entes federados para realização de programas de promoção da saúde, havia sido pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) a estratégia de seleção por meio de editais públicos, em que os municípios se responsabilizavam pelo envio de projetos, os quais eram avaliados e selecionados de acordo com a disponibilidade orçamentária (MALTA et al., 2014).

A partir do ano 2011, visando buscar ações continuadas, sustentáveis e universais relacionadas à promoção da saúde, foram definidas novas modalidades de repasse de recursos. Assim, no âmbito das práticas corporais/atividade física, essas

**FIQUE LIGADO!**

A CIT constitui foros permanentes de negociação, articulação e decisão entre os gestores, nos aspectos operacionais e na construção de pactos nacionais, estaduais e regionais do SUS (BRASIL, s.d.).

definições se voltaram para a implantação do Programa Academia da Saúde. Nesse sentido, os recursos financeiros destinados ao Programa são para custear as ações realizadas nesses espaços, apoiar a construção de estruturas físicas e também pagar iniciativas próprias da saúde de municípios e estados, reconhecidos como similares ao PAS (MALTA et al., 2014). Atualmente, para a construção dos polos, o repasse de verba ocorre por meio de emenda parlamentar, em que o município deve seguir os passos descritos no **Quadro 9**.

Quadro 9: Etapas para a construção de novos polos do PAS

Verificar se o período para cadastro de emendas está aberto.

Promover a articulação entre o gestor municipal e o parlamentar do seu estado (deputado federal ou senador), para que este indique, no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), a emenda para a construção da modalidade do polo do PAS pleiteada pelo município.

Cadastrar e finalizar a proposta no Sistema de Gerenciamento de Objetos e Propostas do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e aguardar análise.

Após a indicação de objeto, o usuário do município cadastrado com CPF deve acessar o Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB) e iniciar o cadastro da proposta nesse outro sistema.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2011, s.d.

**SAIBA MAIS!**

Para obter mais informações sobre a apresentação de propostas ao Ministério da Saúde, acesse aqui a **Cartilha para a Apresentação de Propostas ao Ministério da Saúde – 2022**.



Recentemente, uma nova oportunidade para recebimento de incentivo financeiro relacionado à atividade física na APS foi dada aos gestores de Saúde, pois, por meio da Portaria GM/MS nº 1.105, de 15 de maio de 2022, foi instituído o incentivo financeiro federal de custeio destinado à atividade física no âmbito da APS pelos

municípios e pelo Distrito Federal (BRASIL, 2022). São objetivos desse incentivo financeiro:

- Implementar ações de atividade física na APS, por meio, entre outros mecanismos, da contratação de PEFs; de aquisição de material de consumo; e de qualificação de ambientes relacionados à atividade física.
- Melhorar o cuidado das pessoas com DCNT, mediante a inserção de atividade física na rotina delas.

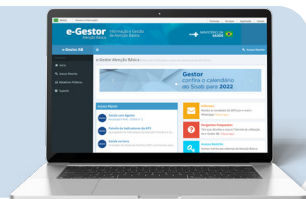
Os municípios habilitados a solicitar o credenciamento são aqueles que apresentam os seguintes estabelecimentos da APS: (1) Posto de Saúde, (2) Centro de Saúde/Unidade Básica e (3) Unidade Móvel Fluvial. A solicitação deverá ser requerida pelos gestores de Saúde por meio do Painel de Credenciamento, disponível no portal e-Gestor (BRASIL, 2022).



SAIBA MAIS!

O e-Gestor é uma plataforma que dá acesso aos vários sistemas de informação da APS.

Clique para acessar.



SAIBA MAIS!

Para saber mais sobre o incentivo financeiro destinado à atividade física no âmbito da APS, de maio de 2022, clique aqui.



REFERÊNCIAS

- BECKER, L. A.; GONÇALVES, P. B.; REIS, R. S. Programas de promoção de atividade física no Sistema Único de Saúde brasileiro: revisão sistemática. **Rev. Bras. Ativ. Fís. Saúde**, v. 21, n. 2, p. 110-22, 2016.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Previne Brasil**. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/gestor/financiamento>.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. **Sistema Único de Saúde – SUS: princípios e conquistas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2000.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Decreto nº 6.286, de 05 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola (PSE) e dá outras providências. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde na escola**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Cadernos de Atenção Básica, no 24).
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à saúde. Departamento de Atenção Básica. **Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Cadernos de Atenção Básica, no 27 – Série A: Normas e Manuais Técnicos).
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Política Nacional de Promoção da Saúde**. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à saúde. Departamento de Atenção Básica. **Passo a passo-PSE: Programa Saúde na Escola – Tecendo caminhos da intersetorialidade**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.
- BRASIL. **Portaria nº 719, de 07 de abril de 2011**. Institui o Programa Academia da Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, 2011.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Série E: Legislação em Saúde).
- BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 12.864, de 24 de setembro de 2013**. Altera o caput do art. 3º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluindo a atividade física como fator determinante e condicionante da saúde. Brasília, 2013.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no Âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2017.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

- BRASIL. Ministério da saúde. Gabinete do Ministério. **Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019**. Institue o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Programa Academia da Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. (Caderno técnico de apoio à implantação e implementação).
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Saúde da família. **Nota técnica nº 3/2020-DES/SAPS/MS**. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) e Programa Previne Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Saúde da família. **Nota Técnica nº 3/2020-DES/SAPS/MS**. Núcleo Ampliado de saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) e Programa Previne Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Manual instrutivo do financiamento da Atenção Primária à Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria GM/MS nº 1.105, de 15 de maio de 2022**. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para instituir o incentivo financeiro federal de custeio, destinado à implementação de ações de atividade física na Atenção Primária à Saúde (APS). Diário Oficial da União, Brasília, 2022.
- CONASS. **Nota técnica 16/2011**. Programa Academia da Saúde. [S.l. : s.n.t.], 2011.
- CONFEE – Conselho Federal de Educação Física. **Resolução CONFEE nº 046/2002**. Dispõe sobre a intervenção do Profissional de Educação Física e respectivas competências e define os seus campos de atuação profissional. [S.l. : s.n.t.], 2002.
- CONFEE – Conselho Federal de Educação Física. **Recomendações sobre condutas e procedimentos do Profissional de Educação Física na Atenção Básica a Saúde**. Rio de Janeiro: CONFEE, 2010.
- CONFEE – Conselho Federal de Educação Física. **Nota Técnica CONFEE nº 002/2012**. Dispõe da avaliação física em programas de exercícios físicos e desportivos. Rio de Janeiro: CONFEE, 2012.

- CONFED – Conselho Federal de Educação Física. Profissional de Educação Física na Saúde está na CBO. **Revista Educação Física**, 2020.
- DA SILVA, D. B. et al. Força de trabalho de profissionais de Educação Física na Atenção Primária à Saúde. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, [S. l.], v. 27, p. 1-9, 2022.
- DA SILVA, P. S. C. **NASF Núcleo de Apoio a Saúde da Família**: aspectos legais, conceitos e possibilidades para a atuação dos profissionais de Educação Física. Palhoça, SC: Ed. Unisul, 2016. 168 p.
- DOS SANTOS, N. R. SUS 30 anos: o início, a caminhada e o rumo. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 23, n. 6, p. 1729-36, 2018.
- FAUSTO, M. C. R. et al. O futuro da Atenção Primária à Saúde no Brasil. **Saúde em Debate**, v. 42, n. 1, p. 12-4, 2018.
- FLORINDO, A. A.; ANDRADE, D. R. **Experiências de promoção da atividade física na Estratégia de Saúde da Família**. Florianópolis: SBAFS – Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, 2015.
- GUERRA, P. H.; DE FARIAS JÚNIOR, J. C.; FLORINDO, A. A. Comportamento sedentário em crianças e adolescentes brasileiros: revisão sistemática. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, p. 1-15, 2016.
- LOCH, M. R.; DIAS, D. F.; RECH, C. R. Apontamentos para a atuação do Profissional de Educação Física na Atenção Básica à Saúde: um ensaio. **Revista Brasileira de Atividade Física & Amp. Saúde**, [S. l.], v. 24, p. 1-5, 2019.
- MALTA, D. et al. A Política Nacional de Promoção da Saúde e a agenda da atividade física no contexto do SUS. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 18, n. 1, p. 79-86, jan.-mar. 2009.
- MALTA, D. et al. Política Nacional de Promoção da Saúde, descrição da implementação do eixo atividade física e práticas corporais, 2006 a 2014. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, [S. l.], v. 19, n. 3, p. 286, 2014.
- MENEGUCI, J. et al. Comportamento sedentário: conceito, implicações fisiológicas e os procedimentos de avaliação. **Motricidade**, v. 11, n. 1, p. 160-74, 2015.
- MIELKE, P. H. G. G. I.; GARCIA, L. M. T. Comportamento Sedentário. **Revista Corpo-consciência**, v. 18, n. 1, p. 23-36, 2014.
- NASCIMENTO, D. D. G.; OLIVEIRA, M. A. de C. Reflexões sobre as competências profissionais para o processo de trabalho nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. **O Mundo da Saúde**, v. 35, n. 1, p. 92-6, 2010.

- OLIVEIRA, I. C.; ROCHA, R. M.; CUTOLO, L. R. A. Algumas palavras sobre o nasf: relatando uma experiência acadêmica. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 36, n. 4, p. 574-80, 2012.
- SPERLING, M. P. R. **Atividade física nos modelos de Atenção Primária à Saúde**. Londrina, PR: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.
- VOTORANTIM – Instituto. **Guia Previne Brasil**. [s.d.]. Disponível em: https://impulsogov.org/wp-content/uploads/2021/07/PREVINE-BRASIL-NOVA-ID_R03-1.pdf.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO Guidelines on physical activity and sedentary behaviour**. [S.l. : s.n.t.], 2020.



CAPÍTULO 2

AUMENTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E DIMINUIÇÃO DO COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO NA APS

Ana Cláudia Pelissari Kravchychyn, Miguel Araújo Carneiro Junior,
Helen Hermana Miranda Hermsdorff

O nível de atividade física é importante preditor de saúde da população, sendo um fator diretamente relacionado ao aumento do bem-estar e com menores possibilidades de doenças que elevam a morbidade e mortalidade do ser humano em todas as fases do seu ciclo de vida. Apesar de seus importantes benefícios, como o controle do peso e a melhoria da qualidade de vida, do humor e da disposição para realizar atividades diárias, o nível de atividade física apresentado pela população brasileira tem diminuído consideravelmente nos últimos anos. Quadro esse que foi agravado ainda mais pelo contexto do isolamento e distanciamento social provocado pela pandemia da COVID-19, que teve seus piores picos entre os anos 2020 e 2021 (PIRANGA et al., 2020; WHO, 2020).

Ressalta-se ainda que a diminuição da atividade física diária não impacta apenas sobre o desfecho do tempo de vida/mortalidade, mas também diminui a sua qualidade ao longo dos anos e gera gastos expressivos (bilhões de reais) para os sistemas de saúde público e privado (ABESO, 2022). A pandemia da COVID-19 tornou todo esse contexto ainda mais visível, pois reduziu os níveis de atividade física que já eram muito discutidos por profissionais da Saúde por serem inferiores ao que se considera ideal para uma população saudável. E isso impactou ainda mais os problemas, como aumento do peso, desenvolvimento de DCNTs, transtornos de humor, depressão e ansiedade e baixa socialização, diminuindo a qualidade de vida e aumentando a morbimortalidade (CREF, 2019; BRASIL, 2021; ABESO, 2022).



GLOSSÁRIO

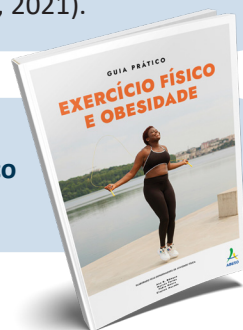
Atividade física: Envolve os movimentos voluntários do corpo, com gasto de energia acima do nível de repouso, o que pode acontecer em diversos momentos do dia (tempo livre, deslocamento, trabalho ou estudo e tarefas domésticas), como: caminhar, correr, pedalar, brincar, subir escadas, carregar objetos, dançar, limpar a casa, passear com animais de estimação, cultivar a terra, cuidar do quintal e praticar esportes, lutas, ginásticas, yoga, entre outros.

Exercício físico: Remete-se a uma atividade física planejada, estruturada em intensidade, volume, tipo e frequência (ABESO, 2022; BRASIL, 2021).



SAIBA MAIS!

Acesse aqui o volume **Guia prático: exercício físico e obesidade**, da Abeso!



Devido às situações anteriormente citadas, desde a segunda metade da década de 1990 surgiram recomendações para o aumento da prática de atividade física geral e estratificada por faixa etária ou por condições específicas, a exemplo de gestação ou de alguma patologia. No entanto, nos últimos anos e em especial após os picos de contágio pandêmico, muito tem se falado sobre o comportamento sedentário e suas consequências (BRASIL, 2021).

O aumento de atividades sedentárias possui como principal causa o desenvolvimento tecnológico, em geral com grandes evoluções nos últimos 30 anos. Os indivíduos nascidos antes da década de 1990 testemunharam esse avanço tecnológico e, muitas vezes, não conseguiram acompanhar todo esse processo devido à sua velocidade. Como exemplos clássicos dessa transição tecnológica, podem ser citadas as facilidades que envolvem o dia a dia da população, como aumento do acesso aos transportes automatizados, a popularização dos televisores e outras tecnologias com controle remoto, maior tempo gasto em atividades que envolvem computadores, videogames, jogos interativos, entre outros, que substituem atividades rotineiras e impactam o nível diário de atividade física da população em geral (OWEN et al., 2010; WHO, 2020).

**GLOSSÁRIO**

Comportamento sedentário: Caracteriza-se como um conjunto de atividades executadas enquanto o indivíduo está acordado, na posição sentada ou deitada, que resultam em gasto energético próximo dos valores de repouso (OWEN et al., 2010).

**FIQUE LIGADO!****Pensando o comportamento sedentário e a atividade física como fatores independentes**

Em meados de 2011, um editorial publicado pela Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde chama a atenção para a dissociação entre a interdependência do comportamento sedentário e a atividade física, em que se discute que em alguns casos é necessário considerar que os efeitos deletérios do comportamento sedentário prolongado nem sempre são revertidos com a prática de atividade física moderada ou intensa. Esse autor alerta para a seguinte questão:



Mesmo nas pessoas que praticam atividades físicas moderadas a vigorosas, o tempo prolongado de comportamento sedentário poderá promover efeitos nocivos à saúde, o que sugere que esse comportamento representa um fator de risco em potencial para a saúde das pessoas. (FARIAS JÚNIOR, 2011).

Esse cenário gera grande desafio aos profissionais da Saúde, em especial aos PEFs, que possuem a tarefa de equilibrar a prática ativa de atividade física com o desenvolvimento tecnológico que cada vez mais consome a população em seu tempo e em suas atividades rotineiras. Assim, em todas as áreas em que essa profissão atua, é de grande valia que estratégias de informação, motivação e conexão com a população-alvo de trabalho sejam revistas e atualizadas (BRASIL, 2021).

Desse modo, é de suma importância a discussão em torno de estratégias que aumentem a prática e adesão a atividades físicas no contexto atual da população, mas que também desestimulem o comportamento sedentário excessivo. Segundo o **Guia de Atividade Física para a População Brasileira**, publicado em 2021 pelo Ministério da Saúde, o setor governamental de Saúde tem importante papel em promover a prática e manutenção adequada de atividade física para a população, bem

como alertas e estratégias para a diminuição das atividades sedentárias diárias, uma vez que, por meio dessas ações, as estratégias efetivas são implementadas. Somado a isso, é fundamental que se discuta a inclusão de outros setores governamentais e não governamentais para o fortalecimento dessas estratégias e a conscientização da população.

O PEF dentro da APS possui função bastante desafiadora e importante, uma vez que lida, de forma direta, com a coordenação, planejamento, organização, avaliação e execução de todos os trabalhos e programas para aumento dos níveis de atividades físicas daquela população-alvo da UBS (CREF, 2019). Pensando em aspectos práticos e de estabelecimento de uma rotina de atividade física, na **Figura 10** se apresenta um compilado de três fatores que pode ser considerado o ideal para o contexto e norteia as vertentes a serem trabalhadas pelos profissionais de Educação Física na APS.



Figura 10: Vertentes do estímulo à atividade física a serem trabalhadas pelos PEFs na APS.

Fonte: Elaboração dos autores.

O **Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região**, em seu documento de Recomendações para a Prática de Atividade Física e Redução do Comportamento Sedentário lançado em 2019, sugere que, diante do aumento do comportamento

sedentário, algumas ações de responsabilidade social podem ser propagadas envolvendo profissionais da Saúde que divulgam o que pode ser feito diariamente para melhorar esses comportamentos (**Figura 11**).

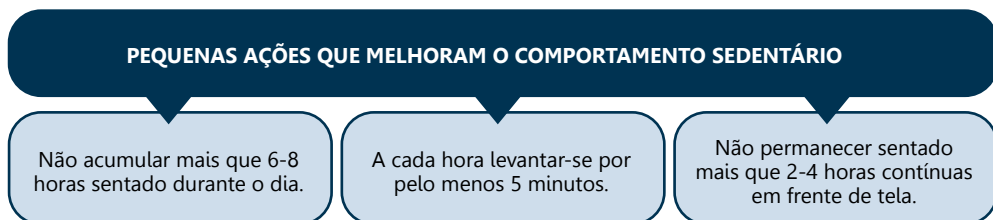


Figura 11: Ações diárias que podem reduzir o comportamento sedentário.

Fonte: Adaptado de CREF, 2019.

Somado ao cuidado em estruturar práticas de atividade física nos três aspectos anteriormente citados, o profissional da Educação Física deve orientar algumas especificidades para melhorar a adesão e a prática da atividade física. Além disso, o perfil integrado com outras áreas da Saúde pode trazer à tona aspectos multidisciplinares da prática de atividade física regular, a fim de promover disseminação de informações uniformes e que melhorem a qualidade de vida na assistência da APS (**Quadro 10**).

Quadro 10: Temas importantes a serem abordados no contexto da atividade física para qualquer faixa etária

Inicie com cautela e tente progredir sempre.

Foque na escolha de atividades físicas prazerosas.

Em casos de doenças e condições específicas, é necessário acompanhamento profissional com maior foco e atenção.

Outros assuntos como sono, nutrição e bem-estar emocional podem ser tratados e discutidos em grupos sobre exercícios físicos.

A mudança de pequenas ações diárias possui impacto imenso sobre o bem-estar físico.

1. Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente

A ciência em torno da saúde na infância e na adolescência se debruça constantemente em entender e justificar quanto que as experiências vividas durante o início da vida são importantes preditores de saúde futura. Quanto mais cedo a prática

da atividade física é incentivada e se torna hábito na vida do indivíduo, maiores os benefícios para sua saúde. Entre esses benefícios para a saúde física, destacam-se o controle do peso; a diminuição da chance de desenvolvimento de alguns tipos de câncer e de DCNTs, como Diabetes Mellitus (DM); doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial e dislipidemias (alterações no perfil de gordura sanguíneo, como colesterol e triglicerídeos); melhora da disposição; melhora da qualidade do sono; e desenvolvimento de habilidades. Para a criança em idade escolar, outros benefícios são observados, como melhora da socialização, do desempenho escolar, do humor, da diminuição da ansiedade e dos sintomas de depressão e estresse (BRASIL, 2021).

Apesar de todos os benefícios da prática regular de atividade física serem amplamente estudados e consolidados, na população de crianças e adolescentes o aumento do comportamento sedentário referente ao tempo gasto para assistir à televisão (incluindo outros meios eletrônicos), sentado ou deitado, foi alarmante e agravado durante a pandemia da COVID-19.



FIQUE LIGADO!

Evidências recentes apontam dados alarmantes de diminuição do nível de atividade física da população em geral, especialmente de adolescentes. O acompanhamento com sensores de movimento durante 22 anos (1995 a 2017) indicou que adolescentes de oito países desenvolvidos estão caminhando 30% a menos, cerca de 1.500 passos, em comparação com os da geração anterior. Além disso, esse estudo estimou que durante esse período, nos EUA, houve um aumento de cinco para nove horas diárias do uso de televisão e celulares por adolescentes, o que caracteriza um total de 38% das horas do dia diante das telas (CONGER et al., 2022).

É importante ressaltar o papel da família no aumento do nível de atividade física de crianças e adolescentes, bem como em diversos aspectos da vida nessa faixa etária. O incentivo à prática de exercício físico precisa partir de dentro de casa e do suporte familiar no tempo livre da criança e do adolescente em dias de semana e nos finais de semana. O entendimento de como a família pode ser o suporte para a prática rotineira de atividade física na infância é um dos pontos-chave para que o PEF consiga acessar as famílias como um todo e conseguir a adesão de crianças às atividades físicas (BRASIL, 2021; SBP, 2017). Exemplos de como a família pode incentivar as crianças e adolescentes à prática de atividades físicas encontram-se na **Figura 12**.

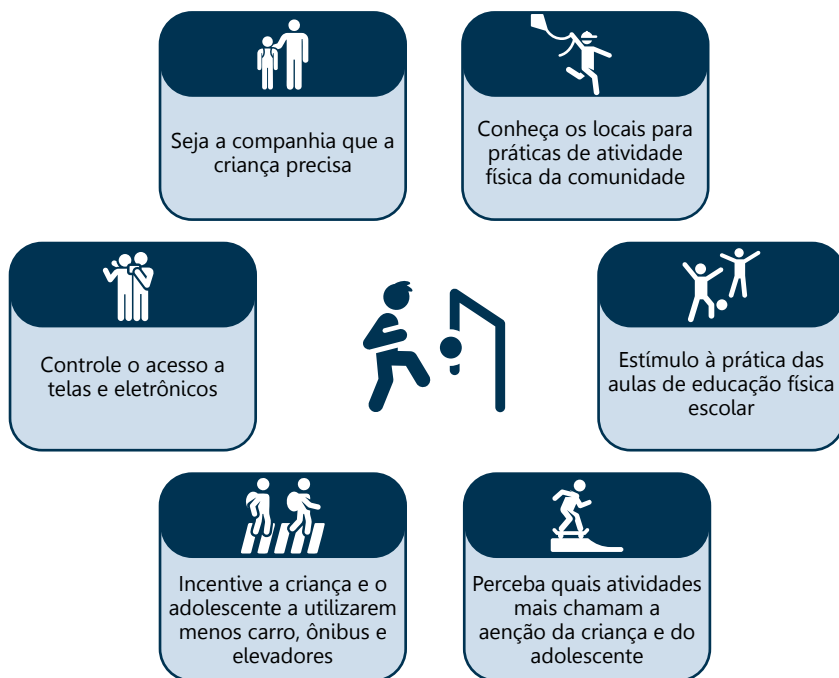


Figura 12: O contexto do estímulo à atividade física na infância e na adolescência.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2021

Tão importante quanto entender a melhor forma de estimular a prática de atividades físicas por crianças e adolescentes é desestimular o comportamento sedentário gerado pelo aumento de práticas tecnológicas diárias nessa faixa etária. A orientação atual é de que o tempo diante de televisores, videogame, computador, celular, entre outros meios tecnológicos, seja reduzido ao máximo. Para crianças menores de 1 ano de idade não são recomendadas telas em nenhum momento, enquanto para crianças na faixa etária de 1 a 5 anos a recomendação é de no máximo uma hora diária de exposição às telas (BRASIL, 2021; SBP, 2017).

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (2009 e 2017), o uso de telas e tecnologias por mais de uma hora por dia pode gerar transtornos que vão além da inatividade física (**Quadro 11**).

Quadro 11: Problemas médicos gerados pelo uso excessivo de tecnologias na infância

Dependência digital
Problemas de saúde mental: irritabilidade, ansiedade e depressão
Transtornos do déficit de atenção e hiperatividade
Transtornos do sono
Transtornos de alimentação: sobrepeso/obesidade e anorexia/bulimia
Sedentarismo e falta da prática de exercícios
<i>Bullying e cyberbullying</i>
Transtornos da imagem corporal e da autoestima
Problemas visuais, miopia e síndrome visual do computador
Problemas auditivos: perda auditiva induzida pelo ruído
Transtornos

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017.

Entre as orientações que podem fazer parte da abordagem para o combate ao comportamento sedentário na APS está a divulgação de problemas médicos e de saúde causados pelo uso indiscriminado e não controlado de tecnologias, como anteriormente citado. Inclui-se nessas diretrizes o entendimento de que a prática de atividades físicas não apenas previne o desenvolvimento dessas condições, como também faz parte do tratamento para a melhora da maioria dessas situações (WHO, 2020; CREF, 2019).

**FIQUE LIGADO!**

É de grande relevância que o PEF entenda e dissemine o uso ético, seguro, saudável e educativo das tecnologias para ajudar no combate ao sedentarismo, que tem gerado muitas consequências para a sociedade atual, principalmente para as faixas etárias pediátricas.

1.1. Como pensar a atividade física e quais as recomendações dessa prática para crianças e adolescentes

A forma de condução desses estímulos para a diminuição do sedentarismo pode ter, em aspectos básicos, duas formas de ação: atividades em programas semanalmente e atividades recreativas (**Figura 13**).

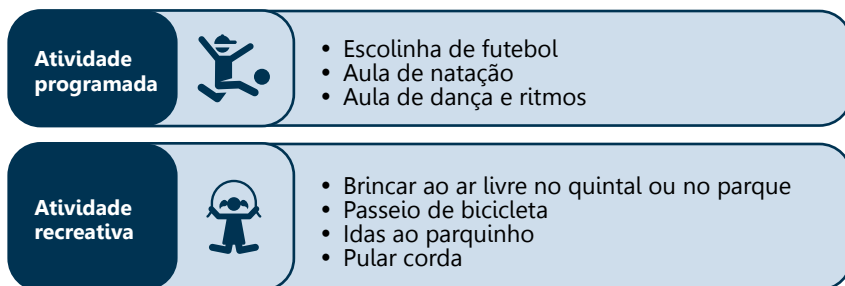


Figura 13: Exemplos de atividades conforme a forma de condução dos estímulos de atividade física na infância.

Fonte: Elaboração dos autores.

Ressalta-se que a prática de atividades físicas nessa faixa etária deve ser compatível com o desenvolvimento neurológico da criança e do adolescente, sempre destacando o lúdico e qual a forma de trabalhá-lo que melhor supre o desenvolvimento físico e cognitivo desse público (CREF, 2019; BRASIL, 2021). De forma interessante, o **Guia de Atividade Física para a População Brasileira** (2021) orienta as recomendações de prática da atividade física para crianças e adolescentes de acordo com as seguintes faixas etárias:

- Atividade física para crianças até 5 anos de idade: bebês; crianças de 1 a 2 anos de idade; e crianças na faixa etária de 3 a 5 anos.
- Atividade física para crianças e jovens de 6 a 17 anos de vida.

No **Quadro 12** é possível visualizar quais atividades e tempo de prática são indicados para cada faixa etária.

Diante do exposto, é possível visualizar que o enfoque da abordagem sobre o aumento da atividade física e a diminuição do comportamento sedentário em crianças e adolescentes gira em torno dos aspectos lúdicos e neurocompatíveis das atividades propostas e do incentivo e conscientização da família para estímulo da criança e do adolescente para a redução do comportamento sedentário, por meio do monitoramento de acesso a telas e eletrônicos.

Quadro 12: Atividades e tempo de prática indicados por faixa etária infantil e de adolescente

	Tempo diário	Atividade atrativa
Crianças até 1 ano de idade	Pelo menos 30 minutos por dia (podendo ser distribuídos ao longo do dia) de barriga para baixo ou atividades fora do carrinho ou do berço, conforme a criança for engatinhando e, ou, ficando em pé com apoios.	Primeiros meses: atividades de barriga para baixo (de bruços). A partir dos 5 meses: estímulos para alcançar, segurar, puxar, empurrar, engatinhar, rastejar, rolar, equilibrar-se com ou sem apoio, sentar e levantar.
Crianças de 1 a 2 anos de idade	Pelo menos 3 horas por dia de atividades físicas de qualquer intensidade (podendo ser distribuídas ao longo do dia).	Brincadeiras lúdicas e jogos que envolvam equilibrar, girar, rastejar, andar, correr, saltitar, escalar, pular, arremessar, lançar, quicar e segurar. Todas essas brincadeiras podem ser guiadas por músicas.
Crianças de 3 a 5 anos de idade	Pelo menos 3 horas por dia de atividades físicas de qualquer intensidade. É importante iniciar atividades de intensidade moderada a vigorosa em alguns períodos do dia.	Brincadeiras e jogos que envolvam atividades como caminhar, correr, girar, chutar, arremessar, saltar e atravessar ou escalar objetos, entre outras. Atividades programadas, como natação, ginástica, lutas, danças e outros esportes. Aulas de Educação Física escolar. Deslocamento ativo, a pé ou de bicicleta, acompanhado dos pais ou responsáveis.
Crianças e jovens de 5 a 17 anos de idade	Sessenta minutos ou mais de atividade física por dia.	Atividades recreativas, como caminhar, correr, empinar pipa, dançar, nadar, pedalar, surfar; jogar futebol, vôlei, basquete, bocha, tênis, peteca ou frescobol; fazer ginástica ou artes marciais; e participar de brincadeiras e jogos, como esconde-esconde, pega-pega, pular corda, saltar elástico, queimada/baleado/carimba/caçador, jogar taco/bete. Atividades programadas, como natação, ginástica, lutas, danças e outros esportes. Aulas de Educação Física escolar. Deslocamento ativo, a pé ou de bicicleta, acompanhado dos pais ou responsáveis. Auxílio em tarefas domésticas.

Fonte: Guia de atividade física para a população brasileira – Brasil, 2021.

2. Atenção à Saúde do Adulto

2.1. O contexto atual da vida adulta

Entende-se por fase adulta dos seres humanos o período de transição entre a adolescência e a velhice, o qual, segundo o **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística** (IBGE), compreende a faixa etária dos 20 aos 59 anos e se caracteriza por ser o período mais produtivo do ciclo da vida humana.

Segundo Borges e Myotin (2019), grandes transformações sociais impactaram o modo de vida adulto atualmente, e o estopim dessa mudança foi a transição do modo de vida rural para o urbano, visando ao acúmulo de capital mediado pelo desenvolvimento industrial e impactando a produtividade da pessoa adulta.

Para a maioria das pessoas nessa faixa etária, a produtividade está relacionada ao trabalho, que se torna um importante componente da vida por conta da renda, dos benefícios, da satisfação com atividades e do contato social. No entanto, todas essas situações de trabalho e produtividade na fase adulta não dizem respeito apenas ao ato de trabalhar e, sim, aos intensos potenciais humanos, englobando o desenvolvimento afetivo, a saúde e a interação social, que refletem, de forma direta, a satisfação do trabalho profissional (IBGE, 2019) (**Figura 14**).



Figura 14: Aspectos importantes para a qualidade de vida e a saúde na fase adulta.

Fonte: Elaboração dos autores.

A geração de adultos atual nascida até a década de 1990 experimentou uma grande mudança tecnológica e precisa lidar constantemente com o aumento de estímulos aos comportamentos sedentários e ao perfil de trabalho em relação aos adultos que viveram nas décadas de 1970 e 1980 (**Quadro 13**).

Quadro 13: Diferenças no perfil de trabalho após o desenvolvimento tecnológico

Perfil de trabalho dos anos de 1970 e 1980	Perfil de trabalho após os anos de 1990
Máquina de escrever	Computador, <i>tablet</i> , celulares
Ausência da internet	Acesso à internet, inicialmente discada e posteriormente móvel
Comunicação via telefone fixo, fax e beep (era raro a pessoa que tinha um celular)	Evolução dos celulares e aplicativos que mantêm pessoas conectadas fora do horário de trabalho
Reuniões presenciais	Reuniões possíveis de serem feitas virtualmente
Trabalho em <i>home office</i> era raro	Aumento da possibilidade de trabalho em <i>Home Office</i>

Fonte: Adaptada de Borges e Myotín, 2019.

Ao se observarem os aspectos abordados no Quadro 13 juntamente com o desenvolvimento de transporte, facilidades alimentares, controles remotos para eletrodomésticos e carga de trabalho mental e social elevada, fica nítido quanto o aumento do comportamento sedentário é inevitável. Fato esse que impacta fortemente o quadro de saúde atual da população adulta que, cada vez mais cedo, desenvolve doenças vinculadas ao excesso de peso e à inatividade física (BRASIL, 2019; BORGES; MYOTIN, 2019).

Além dos problemas físicos causados pela demanda da vida adulta, atualmente os problemas psicológicos ganharam força por conta de toda a produtividade cobrada pela sociedade dessa faixa etária. É relevante e notória a quantidade de pessoas adultas com dificuldades de lidar com o cenário atual das cobranças em torno da produtividade. Por não conseguirem dissociar momentos de trabalho e de lazer, esses adultos enfrentam obstáculos para se desconectar do trabalho por conta das facilidades tecnológicas e da internet, razão por que acabam desenvolvendo problemas psicológicos e sociais (CREF, 2019).

A atenção à saúde do adulto e a prevenção de doenças associadas ao estilo de vida que hoje se desenha no cenário atual perpassam pela atividade física rotineira e pela conscientização de sua importância para aspectos além da saúde física, mas mental e social como um todo (**Quadro 14**).

Quadro 14: Atividades e tempo de prática indicados para adultos com base no Guia de Atividade Física para a População Brasileira

	Tempo semanal	Exemplo de atividade
Atividades físicas moderadas	150 minutos por semana	Caminhar, correr, dançar, nadar, pedalar, surfar, praticar esportes coletivos, pilates, treinamento funcional, fazer ginástica/hidroginástica ou artes marciais.
Atividades físicas vigorosas	75 minutos por semana	Caminhar, correr, dançar, nadar, pedalar, surfar, jogar esportes coletivos, fazer ginástica ou artes marciais com intensidade mais elevada, sob orientação para aumento das frequências cardíaca e respiratória.
Atividades de fortalecimento dos músculos e ossos	No mínimo 2 vezes na semana	Musculação Exercícios com sobrecarga externa ou do peso do corpo
Atividades físicas ligadas à rotina do dia a dia	Diariamente	Seguir as recomendações para diminuição de comportamento sedentário Deslocamento ativo, como a pé ou de bicicleta. Desenvolvimento de tarefas domésticas. Atividades recreativas e de lazer.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2021.

3. Atenção à Saúde da Pessoa Idosa

3.1. O Contexto Social da Pessoa Idosa

A transição demográfica foi projetada e hoje em dia é visível no Brasil, uma vez que a expectativa de vida tem aumentado de forma positiva e a qualidade de vida de idosos, mesmo que com algumas comorbidades, tem aumentado também. O aumento da expectativa de vida também tem modificado o perfil da população idosa atualmente, que se encontra mais aberta para atividades cotidianas e socialização. Os idosos, sem dúvida, são o público de maior participação em atividades da Atenção Primária à Saúde e se caracterizam como parcela da população que merece atenção física, psicológica e de socialização (BRASIL, 2019).

Nesse contexto de atenção, a atividade física contribui, de forma efetiva, em todos os âmbitos (**Figura 15**). Com o envelhecimento e os fatores a ele associados, a capacidade funcional do ser humano é diminuída a ponto de comprometer a sua independência e autonomia na realização das atividades da vida diária. Vale ressaltar que esse prejuízo não é apenas para o corpo, mas também emocional, comprometendo, como em um ciclo vicioso, a qualidade de vida e o desempenho físico (BRASIL, 2006).

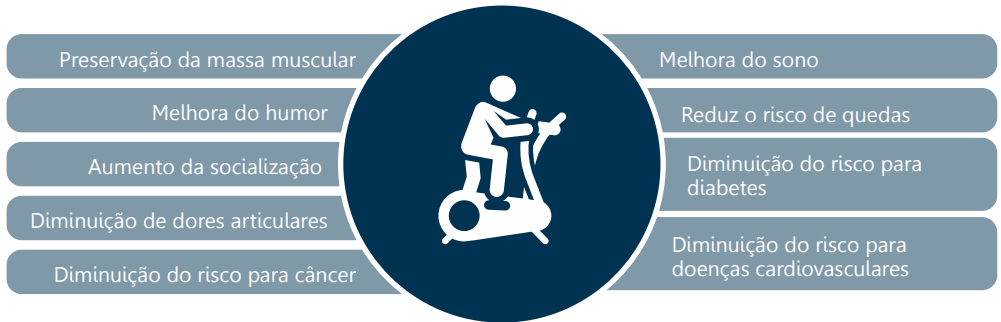


Figura 15: Benefícios da atividade física regular para a terceira idade.

Fonte: Adaptada de CREF, 2019.

Para que a pessoa idosa possa colher os benefícios de uma prática regular de atividade física são importantes alguns cuidados adicionais, que vão além das recomendações de tempo e intensidade da prática. Segundo os Cadernos de Atenção Básica (BRASIL, 2006) para assistência à pessoa idosa, os profissionais responsáveis pela instrução da atividade física devem se atentar para que:

- Sempre haja avaliação de saúde antes de iniciar quaisquer práticas corporais/atividades físicas.
- O trabalho em grupo é uma importante estratégia de adesão e socialização para a pessoa idosa.
- Fatores como o incentivo de amigos e familiares, a procura por companhia ou ocupação, alguns programas específicos de atividade física e, principalmente, a orientação do profissional de saúde para estimular a população idosa a adotar um estilo de vida mais saudável e ativo são facilitadores para a incorporação da prática de atividade física à rotina desse público.
- As práticas corporais/atividades físicas devem ser de fácil realização e não provocar lesões.
- A atividade física para uma pessoa idosa deve ser indicada considerando: prazer em estar realizando esta ou aquela atividade, suas necessidades físicas e suas características sociais e psicológicas.

Após atentar para todos os aspectos de cuidado e rotina citados, no **Quadro 15** são descritas, com base no Guia de Atividade Física para a População Brasileira, as recomendações de atividades físicas seguras para essa população.

Quadro 15: Atividades e tempo de prática indicados para a pessoa idosa, com base no Guia de Atividade Física para a População Brasileira

	Tempo semanal	Exemplo de atividade	Observação
Atividades físicas moderadas	150 minutos por semana	Caminhar, correr, dançar, nadar, pilates, treinamento funcional, jogar esportes coletivos, fazer ginástica/hidroginástica ou artes marciais.	
Atividades físicas vigorosas	75 minutos por semana	Caminhar, correr, dançar, nadar, praticar esportes coletivos, ginástica ou artes marciais em intensidade mais elevada, com orientação para aumento das frequências cardíaca e respiratória.	Se atentar para os limites corporais da idade, principalmente vinculados a condições e doenças existentes. Os exercícios vigorosos devem ser acompanhados por um profissional qualificado e após liberação médica.
Atividades de fortalecimento dos músculos e ossos	2 a 3 vezes na semana em dias alternados	Musculação. Exercícios com sobrecarga externa ou do peso do corpo.	Priorize grandes grupos musculares: braços, peitorais, ombros, costas, abdômen e pernas. A carga adequada irá depender do nível de força e das limitações individuais.
Atividades de equilíbrio	2 a 3 vezes na semana em dias alternados	Treinamento funcional Pilates.	Podem ser trabalhadas atividades que resgatem atividades cotidianas, como amarrar os sapatos, subir um meio fio, alcançar algo no alto etc.
Atividades físicas ligadas à rotina do dia a dia	Diariamente	Seguir as recomendações para diminuição de comportamento sedentário. Deslocamento ativo, como a pé ou de bicicleta, sempre acompanhados quando necessário. Desenvolvimento de tarefas domésticas. Atividades recreativas e de lazer.	O resgate da autonomia e a independência dada por meio dessas atividades físicas do cotidiano possuem forte benefício físico e psicológico.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2021.

4. Atenção à Pessoa com Obesidade

4.1. O contexto da obesidade

A obesidade representa, mundialmente, um problema de saúde pública caracterizado pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo gerado pelo desbalanço da ingestão de alimentos com diminuição do gasto de energia, predominantemente associado ao estilo

de vida sedentário e ao aumento do consumo de alimentos calóricos e não nutritivos, com impacto negativo sobre a saúde corporal e emocional (ABESO, 2022; BRASIL, 2006).

Em pessoas com sobrepeso e obesidade, o baixo nível de atividade pode causar problemas que vão além do aumento dos depósitos de gordura no organismo, como a diminuição do percentual de massa muscular e o aumento dos aspectos inflamatórios, o que contribui, de forma intensa, para o desenvolvimento de doenças associadas à obesidade e agrava o quadro de saúde do indivíduo (BLÜHER, 2019). A alta taxa de morbidade e mortalidade ocasionadas pelo sobrepeso e pela obesidade é o que chama atenção para essa doença e o que preocupa a maioria dos profissionais da Saúde. Isso porque o indivíduo acometido por essa patologia passa a dar “mais atenção” a ela quando desenvolve alguma doença associada que, em geral, é silenciosa e impacta sobre sua qualidade de vida e o coloca em risco de morte (ZATTERALE et al., 2020).



FIQUE LIGADO!

Muitos estudos demonstram que pessoas com obesidade vão a óbito por problemas cardiovasculares e complicações do DM quando comparadas com aquelas com peso adequado (BRASIL, 2006).

Entre as principais comorbidades associadas à obesidade, destacam-se as doenças cardiovasculares e o Diabetes Mellitus II (DM2) ocasionado por agravos metabólicos; as doenças psicológicas, como depressão e ansiedade; e os transtornos alimentares, como a bulimia e a compulsão alimentar (ZATTERALE et al., 2020). Além disso, a obesidade, em qualquer faixa etária, desencadeia prejuízos sociais e auto-estima, pois grande parcela de pessoas acometidas pela obesidade não escapa da pressão dos padrões estéticos de cultura à magreza e à beleza e são alvos constantes de bullying (KIM et al., 2011).



GLOSSÁRIO

A expressão inglesa **bullying** vem do verbo to **bully**, que significa tratar alguém de forma grosseira e desumana. O **bullying** torna-se um ato abusivo e agressivo, manifestado por meio de gestos, palavras, atitudes, comportamentos ou qualquer outro meio de forma intencional e repetitiva que atenta contra a dignidade e integridade física e psíquica de uma ou mais pessoas. Pode ser praticado de modos físico, verbal, relacional e eletrônico (**cyberbullying**).

O sedentarismo e o aumento do comportamento sedentário, tão comuns na sociedade moderna por conta de uma transição ocorrida com o desenvolvimento industrial e eletrônico, são um forte determinante para o desenvolvimento da obesidade, uma vez que impacta negativamente sobre um importante fator no saldo final de energia gasta por indivíduo ao final do dia. Esse cenário é relevante não só com relação a aspectos como diminuição do tempo e qualidade de vida ao longo dos anos, uma vez que também gera gastos de bilhões de reais para os sistemas de saúde público e privado (ABESO, 2022).

O combate aos baixos níveis de atividade física e ao comportamento sedentário é uma estratégia necessária para a melhora da saúde da população que sofre com o excesso de peso. Em inúmeros documentos e pesquisas, os benefícios de uma prática diária de atividades físicas (**Figura 16**) são vistos e incentivados e devem ser propagados à população por meio de estratégias e programas que incentivem o aumento dessa prática.



Figura 16: Benefícios da prática regular de atividade física para pessoas com sobrepeso e obesidade.

Fonte: Adaptada de Abeso, 2022.

Diante dos benefícios citados, faz-se necessário o destaque da prática segura, seguindo recomendações para as características dessa população (**Quadro 16**).

Quadro 16: Atividades e tempo de prática indicados para pessoas com sobrepeso e obesidade

	Tempo semanal	Exemplo de atividade	Observação
Atividades físicas moderadas	Mínimo 150 minutos por semana	Caminhar, correr, dançar, nadar, pedalar, surfar, praticar esportes coletivos, pilates, treinamento funcional e fazer ginástica/hidroginástica ou artes marciais.	O ideal para pessoas com sobrepeso e obesidade: de 250 a 300 minutos por semana.
Atividades físicas vigorosas	75 minutos por semana	Caminhar, correr, dançar, nadar, pedalar, surfar, jogar esportes coletivos, fazer ginástica ou artes marciais em intensidade mais elevada, com orientação para aumento das frequências cardíaca e respiratória.	Se atentar aos limites corporais do sobrepeso, principalmente articulares e respiratórios. Os exercícios vigorosos devem ser acompanhados por um profissional qualificado e após liberação médica.
Atividades de fortalecimento dos músculos e ossos	No mínimo 2 vezes na semana	Musculação Exercícios com sobrecarga externa ou do peso do corpo.	Priorize grandes grupos musculares: braços, peitorais, ombros, costas, abdômen e pernas. A carga adequada irá depender do nível de força e das limitações individuais.
Atividades físicas ligadas à rotina do dia a dia	Diariamente	Seguir as recomendações para diminuição de comportamento sedentário. Deslocamento ativo, como a pé ou de bicicleta. Desenvolvimento de tarefas domésticas. Atividades recreativas e de lazer.	

Fonte: Adaptado de Abeso, 2022.

4.2. Sugestão de cuidados físicos a serem feitos pelo PEF para o melhor acompanhamento da pessoa com sobrepeso e obesidade

Considerando todos os aspectos citados, desde malefícios do excesso de peso até os benefícios de uma prática regular de atividades físicas, é importante que o PEF, dentro da APS, tome cuidados que vão além das atividades físicas em si, atendo-se para aspectos físicos que podem limitar a prática dessas atividades, a fim de prestar melhor assistência a essa população (CREF, 2019; SAÚDE, 2006). Assim, é imprescindível que algumas recomendações sejam passadas antes do início da prática das atividades e de forma rotineira para quem tem excesso de peso (**Figura 17**).



Figura 17: Aspectos importantes a serem acompanhados antes e durante a atividade física de pessoas com sobrepeso e obesidade.

Fonte: Adaptada de CREF, 2019.

5. Atenção à Pessoa com Hipertensão Arterial Sistêmica

5.1. O contexto da Hipertensão Arterial Sistêmica

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição multifatorial que pode ser dependente de fatores genéticos, ambientais e sociais. Chamada popularmente de “pressão alta”, é considerada uma DCNT e pode ser definida, segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2020), por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento não medicamentoso e, ou, medicamentoso superam os riscos. Em todo o mundo, inclusive no Brasil, as Doenças Cardiovasculares (DCV) são a principal causa de óbitos e hospitalizações. Dados do DATASUS apontam que no ano 2017 as DCV foram responsáveis por 27,3% dos óbitos totais, estando 45% dessas mortes relacionadas à HAS (BARROSO et al., 2021).

Nesse contexto, a HAS é caracterizada por constante elevação da Pressão Arterial Sistólica (PAS) superior ou igual a 140 mmHg e, ou, Pressão Arterial Diastólica (PAD) superior ou igual a 90 mmHg, em pelo menos duas ocasiões diferentes, na ausência de medicação anti-hipertensiva (BARROSO et al., 2021).

Por sua característica multifatorial, vários são os fatores de risco modificáveis e não modificáveis que contribuem para o desenvolvimento da HAS, como: sexo, obesidade, Diabetes Mellitus, sedentarismo, tabagismo, excesso de sal na alimentação, ingestão de bebida alcoólica, hereditariedade, idade e etnia (MALACHIAS et al., 2016). Existem vários tratamentos diferentes para HAS, entre eles os medicamentosos e os não medicamentosos, que incluem, em sua grande maioria, a mudança no

estilo de vida pelo aumento do nível de atividade física. Na **Figura 18** estão descritos os fatores de risco modificáveis e não modificáveis para HAS.



Figura 18: Fatores de risco modificáveis e não modificáveis para o desenvolvimento da HAS.

Fonte: Adaptada de Barroso et al., 2020.

Além de compor um fator de risco possível de ser modificado, o aumento do nível de atividade física e a redução do sedentarismo são tidos como principais meios de intervenções não farmacológicas para o tratamento e controle da HAS, interferindo, inclusive, em outros tratamentos não farmacológicos sugeridos, como o controle do peso (**Figura 19**).



Figura 19: Tratamento não farmacológico para HAS sugerido pelas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial .

Fonte: Adaptada de Barroso et al., 2020.

De acordo com essas informações, é possível perceber que a atividade física está envolvida com a HAS tanto como um fator de risco – no caso de o seu nível estar baixo – quanto em uma proposta de tratamento não medicamentoso. Por conta dessa importância, é imprescindível que o cuidado com o paciente com HAS na APS envolva melhora no seu nível de atividade física, promovendo informações sobre a necessidade da redução de comportamentos sedentários, aumento da rotina de

atividade física em práticas rotineiras diárias e incremento de atividades físicas/exercícios físicos orientados e estruturados (**Quadro 17**).

Quadro 17: Atividades e tempo de prática indicados para pessoas com HAS

	Tempo semanal	Exemplo de atividades	Observação
Atividades físicas moderadas	Mínimo 150 minutos por semana	Caminhar, correr, dançar, nadar, pedalar, surfar, jogar esportes coletivos, pilates, treinamento funcional, fazer ginástica/hidroginástica ou artes marciais.	Indivíduos hipertensos com comorbidades, sintomas ou que pretendem fazer atividades de alta intensidade ou competitivas devem se submeter à avaliação médica prévia.
Atividades físicas vigorosas	75 minutos por semana	Caminhar, correr, dançar, nadar, pedalar, surfar, jogar esportes coletivos, fazer ginástica ou artes marciais em intensidade mais elevada, com orientação para aumento da frequência cardíaca e frequência respiratória.	A sessão de treinamento não deve ser realizada se a PA estiver acima de 160/105 mmHg, e recomenda-se medir a PA durante o exercício aeróbico em hipertensos hiper-reativos e diminuir a intensidade se ela estiver acima de 180/105 mmHg.
Atividades de fortalecimento dos músculos e ossos	No mínimo 2 vezes na semana	Musculação. Exercícios com sobrecarga externa ou do peso do corpo.	Priorize grandes grupos musculares: braços, peitorais, ombros, costas, abdômen e pernas. A carga adequada irá depender do nível de força e das limitações individuais.
Atividades físicas ligadas à rotina do dia a dia	Diariamente	Seguir as recomendações para diminuição de comportamento sedentário. Deslocamento ativo, como a pé ou de bicicleta. Desenvolvimento de tarefas domésticas. Atividades recreativas e de lazer.	

Fonte: Adaptado de Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (BARROSO et al., 2020) e Diretrizes para Atividade Física e Comportamento Sedentário/Organização Mundial da Saúde (2020).

6. Atenção à Pessoa com *Diabetes Mellitus*

6.1. O contexto do *Diabetes Mellitus*

O DM (**Quadro 18**) é considerado problema de saúde pública por conta de sua alta prevalência e possibilidades de complicações em todas as faixas etárias. Estima-se que a cada 11 pessoas uma possui diabetes, totalizando 463 milhões de portadores no mundo. Ainda de acordo com as estatísticas, as perspectivas são de aumento de 51% nos diagnósticos, chegando a 700 milhões de pessoas com a doença em 2045. Arelado ao alarmante número de diabéticos, cerca de 50% deles não possuem conhecimento de seu diagnóstico – totalizando, assim, uma em cada três pessoas –, e 44% das mortes causadas pela doença são de pessoas com menos de 60 anos de idade (RODACKI, 2022; CREF, 2019).

Quadro 18: Classificações do *Diabetes Mellitus*

O DM pode ser classificado em	
<i>Diabetes Mellitus</i> tipo 1 (DM1)	Caracterizado por falência total da célula betapancreática, atacando geralmente indivíduos de idades abaixo de 30 anos.
<i>Diabetes Mellitus</i> tipo 2 (DM2)	É a doença metabólica mais prevalente no mundo, em que não há morte total da célula beta e, sim, a sua incapacidade de exercer sua função; esta classificação normalmente acomete pessoas com idade acima dos 30 anos.
Diabetes gestacional	É uma condição metabólica exclusiva da gestação e reversível na maioria dos casos, em que ocorre o aumento da resistência insulínica causada pelos hormônios gestacionais.

Fonte: Rodacki, 2022.

Por conta da alta prevalência do Diabetes Mellitus, em especial do DM2, o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento de pessoas que possam ter a doença por meio dos fatores de risco, uma vez que o DM pode ser uma doença silenciosa, com aparecimento de sintomas tardiamente (BRASIL, 2006). No **Quadro 19** são apresentados, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, os fatores de risco para o desenvolvimento de DM.

Quadro 19: Fatores de risco para o desenvolvimento de DM2

Idade superior a 45 anos
Sobrepeso (IMC ≥ 25 kg/m ²)
Obesidade central (cintura abdominal >102 cm para homens e >88 cm para mulheres)
História familiar de <i>Diabetes Mellitus</i>
Hipertensão arterial ($>140/90$ mmHg)
Doença cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica
Colesterol HDL <35 mg/dl e, ou, triglicerídeos >150 mg/dl
História de macrosomia ou diabetes gestacional
Diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos
Acantose nigricans (Doença de pele caracterizada por manchas aveludadas e escuras em dobras e vincos do corpo)

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019.

O baixo nível de aptidão física e o sedentarismo estão entre os fatores que pioram o quadro de Diabetes Mellitus e estão relacionados a uma elevada taxa de mortalidade em pacientes com DM (WHO, 2020). Para contribuir positivamente com o prognóstico, somado à dieta e ao uso de medicamentos, a prática de exercícios físicos é considerada um dos três pilares da prevenção e tratamento de DM (**Figura 20 e Quadro 20**).

**Figura 20:** Benefícios do exercício físico para pacientes com DM.

Fonte: Adaptada de WHO, 2020.

Quadro 20: Atividades e tempo de prática indicados para pessoas com diabetes

	Tempo semanal	Exemplo de atividades	Observação
Atividades físicas moderadas	Mínimo de 150 minutos por semana	Caminhar, correr, dançar, nadar, pedalar, surfar, jogar esportes coletivos, pilates e treinamento funcional, fazer ginástica/hidroginástica ou artes marciais.	Atividades físicas de intensidade mais elevada realizadas três vezes/semana produzem efeitos similares aos das executadas diariamente com menor intensidade. Porém, na impossibilidade de supervisão mais individualizada para atividades vigorosas, o PEF deve priorizar a atividade moderada feita com segurança.
Atividades físicas vigorosas	75 minutos por semana	Caminhar, correr, dançar, nadar, pedalar, surfar, jogar esportes coletivos, fazer ginástica ou artes marciais com intensidade mais elevada, com orientação para aumento das frequências cardíaca e respiratória.	
Atividades de fortalecimento dos músculos e ossos	No mínimo 2 vezes na semana	Musculação. Exercícios com sobrecarga externa ou do peso do corpo.	Priorize grandes grupos musculares: braços, peitorais, ombros, costas, abdômen e pernas. A carga adequada irá depender do nível de força e das limitações individuais.
Atividades físicas ligadas à rotina do dia a dia	Diariamente	Seguir as recomendações para diminuição de comportamento sedentário. Deslocamento ativo, como a pé ou de bicicleta. Desenvolvimento de tarefas domésticas. Atividades recreativas e de lazer.	

Fonte: Adaptado de CREF, 2019; Junior et al., 2022.

Somado às recomendações de práticas de atividade física e exercícios físicos estruturados para controle e melhor qualidade de vida de pessoas acometidas de DM, destaca-se que alguns cuidados físicos precisam ser informados e monitorados pelo PEF, para melhor acompanhamento da pessoa diabética (**Figura 21**).



Cuidados a serem orientados pelos professores de educação física antes da prática de atividade física (AF)

Testar a glicose antes e depois da AF é essencial e caso o exercício se prolongue por mais de 40 minutos é importante fazer um teste durante o exercício.

É imprescindível ter sempre à disposição alguma fonte de carboidrato de rápida absorção em casos de hipoglicemia. Exemplos: sachê de mel, gel de carboidrato, isotônicos, suco de laranja, maltodextrina ou dextrose.

Fale para o paciente perceber como a sua glicose responde diante de cada tipo de exercício.

Diabéticos que se exercitam desacompanhados devem portar cartão de identificação.

De preferência a atividade deve ser realizada sempre no mesmo horário do dia e que não ocorra muita alteração da intensidade e duração, principalmente quando este for realizado em dias mais quentes.

A hidratação é fundamental, pois a hiperglicemia facilita a desidratação.

Não é indicado a aplicação de insulina da área ser exercitada (o aumento da vascularização no músculo pode fazer a absorção ser mais rápida e pode gerar hipoglicemia).

Instrua os portadores de diabetes a terem hábito de inspecionar os pés antes e depois da atividade física, a fim de identificar precocemente bolhas, pequenas feridas e rachaduras.

Figura 21: Cuidados a serem tomados no monitoramento da atividade física de pessoas com *Diabetes Mellitus*.

Fonte: Adaptada de Junior et al., 2022.

REFERÊNCIAS

ABESO – Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica.

Guia Prático: exercício físico e obesidade. [S.l. : s.n.t.], 2022.

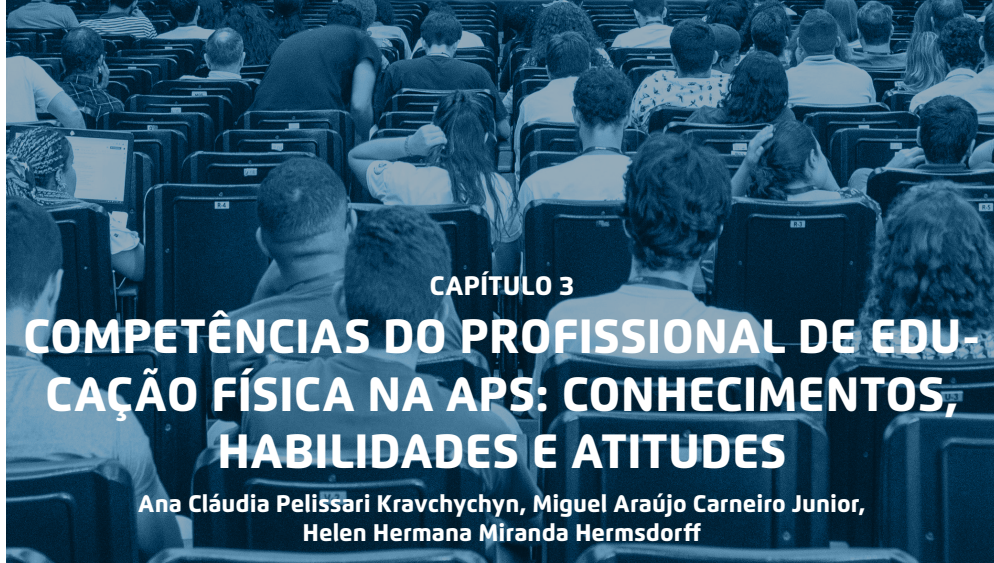
BARROSO, W. K. S. et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. **Arq. Bras. Cardiol.**, v. 116, n. 3, p. 516-658, 2021.

BLÜHER, M. Obesity: global epidemiology and pathogenesis. **Nat. Rev. Endocrinol.**, v. 15, n. 5, p. 288-98, 2019.

BORGES, K. E. L.; MYOTIN, E. **Educação Física:** atenção à saúde do adulto. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2019.

- BRASIL – Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Envelhecimento e saúde da pessoa idosa**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
- BRASIL – Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Diabetes Mellitus**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
- BRASIL – Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. **Síntese de evidências para políticas de saúde: atividade física e prevenção/controla da hipertensão arterial na Atenção Primária à Saúde (APS) e Prevenção e controle da dengue no espaço urbano**. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
- BRASIL – Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. **Guia de Atividade Física para a População Brasileira**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.
- CONGER, S. A. et al. Time Trends in Physical Activity Using Wearable Devices: a systematic review and meta-analysis of studies from 1995 to 2017. **Med. Sci. Sports Exerc.**, v. 54, n. 2, p. 288-98, 2022.
- CREF – Conselho Regional de Educação Física da 4ª região. **Recomendações para prática de atividade física e redução do comportamento sedentário**. [S. l. : s.n.t.], 2019.
- FARIAS JÚNIOR, J. C. Atividade física e comportamento sedentário: estamos caminhando para uma mudança de paradigma? **Rev. Bras. Ativ. Saúde**, v. 16, n. 4, p. 279-80, 2011.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira – IBGE: Coordenação de População e Indicadores Sociais**. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.
- JUNIOR, W. et al. **Atividade física e exercício no pré-diabetes e DM2**. [S.l.]: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2022.
- KIM, M. J. et al. Bullying at elementary school and problem behaviour in young adulthood: a study of bullying, violence and substance use from age 11 to age 21. **Crim. Behav. Ment Health.**, v. 21, n. 2, p. 136-44, 2011.
- MALACHIAS, M. V. B. et al. 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. **Arq. Bras. Cardiol.**, v. 107, n. 3, p. 1-83, 2016. (Supl. 3).
- OWEN, N. et al. Too much sitting: the population health science of sedentary behavior. **Exerc. Sport. Sci. Rev.**, v. 38, n. 3, p. 105-13, 2010.
- PIRANGA, J. F. G. et al. Inatividade física, obesidade e COVID-19: perspectivas entre

- múltiplas pandemias. **Rev. Bras. Ativ. Fís. Saúde**, v. 25, p. e0114, 2020.
- RODACKI, M. et al. **Classificação do diabetes**. [S.l.]: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2022.
- SBD – Sociedade Brasileira de Diabetes. **Classificação e diagnóstico do diabetes mellitus**. [S.l.]: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019.
- SBO – Sociedade Brasileira de Pediatria. **Atividade física na infância e na adolescência – Guia prático para o pediatra**. [S.l.]: Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, 2009.
- SBO – Sociedade Brasileira de Pediatria. **Promoção da Atividade Física na Infância e Adolescência**. [S.l. : s.n.t.], 2017. (Grupo de Trabalho em Atividade Física).
- WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO Guidelines on physical activity and sedentary behavior**. [S.l.]: WHO, 2020.
- ZATTERALE, F. et al. Chronic adipose tissue inflammation linking obesity to insulin resistance and Type 2 diabetes. **Front Physiol.**, v. 29, n. 10, p. 1607, 2020.



CAPÍTULO 3

COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA APS: CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES

Ana Cláudia Pelissari Kravchychyn, Miguel Araújo Carneiro Junior,
Helen Hermana Miranda Hermsdorff

Nos últimos 30 anos, o aumento da disseminação dos benefícios de se ter uma vida fisicamente ativa fez que o cuidado com o corpo fosse entendido como importante e os profissionais orientassem como esse cuidado poderia ser feito dentro da APS. Atualmente, muitos avanços em relação ao papel do PEF na APS podem ser observados, e as práticas corporais e atividades físicas são ferramentas que auxiliam na implementação do modelo assistencial no Sistema Único de Saúde (SUS) (OLIVEIRA; WACHS, 2019).

Como apresentado no Capítulo 1, segundo o Ministério da Saúde, por meio da divulgação dos Cadernos de Atenção Básica, entende-se que os:



Núcleos de Apoio à Saúde da Família são equipes multiprofissionais, compostas por profissionais de diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e das equipes de Atenção Básica para populações específicas (SAÚDE, 2014).

Essas equipes, desde o ano 2020, foram reestruturadas em sua forma de credenciamento, porém o PEF continua cotado como importante membro a compor as equipes multiprofissionais que amparam a condição de saúde como um todo.

O PEF compõe as equipes multidisciplinares com o intuito de contribuir em discussões de estratégias para o entendimento de prevenções e tratamentos que venham respaldar o atual modelo de apoio matricial, trazendo sua especialidade voltada para o cuidado físico, por meio de atividades e práticas corporais (**Quadro 21**).

No ano 2020, por meio da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o Ministério do Trabalho fez a inclusão Número 2241-40 no perfil do PEF, que passou a ter em sua descrição o seguinte texto:



Profissional de Educação Física na Saúde, que possui como competência a estruturação e realização de ações de promoção da saúde mediante práticas corporais, atividades físicas e de lazer na prevenção primária, secundária e terciária no SUS e no setor privado (CONFEEF, 2020).

Quadro 21: Diferenças de abordagem do indivíduo na APS entre o Modelo Tradicional e o Modelo de Apoio Matricial

Atenção à pessoa com DM tipo 2	
Modelo tradicional	Modelo de apoio matricial
• Encaminhar as pessoas para agendamento de consulta individual com o nutricionista para orientações alimentares e nutricionais. • Encaminhar as pessoas para agendamento de visita domiciliar do farmacêutico para avaliação da adesão aos medicamentos. • Encaminhar as pessoas ao PEF para prática coletiva de atividade física. • Encaminhar as pessoas para o endocrinologista.	• Discutir o tema “Diabetes Mellitus” e estratégias para seu controle com os profissionais da equipe multiprofissional (psicólogo, assistente social, PEF e nutricionista, entre outros). • Discutir com os profissionais propostas de ações e condutas que a própria equipe de AB poderia realizar individual ou coletivamente. • Planejar e realizar intervenções conjuntas (atendimentos individuais ou coletivos, atendimentos domiciliares, atividades no território etc.). • Pactuar intervenções específicas dos profissionais da equipe com discussão e repactuação permanentes com a equipe de referência. • Construir Projetos Terapêuticos Singulares para os casos mais difíceis ou complexos.

Fonte: Adaptada de Borges e Myotín, 2019.

O modelo de apoio matricial implantado causou modificações no perfil dos profissionais, inclusive da área da Educação Física. Segundo Coutinho (2011), o PEF, que antes compunha o sistema de saúde atrelado a projetos com grupos populacionais específicos como idosos, hipertensos e diabéticos, entre outros, tem sido estimulado a se envolver na atuação com a população e compor as equipes de saúde com projetos de promoção à saúde e de intervenção interdisciplinar, estruturação de políticas públicas e ações governamentais que visem consolidar a prática de atividade física como importante pilar dentro da APS.

Nessa perspectiva, é de suma importância que as competências a serem desenvolvidas pelo PEF caminhem em direção ao modelo de apoio matricial, indo além do papel do entendimento específico de atividade física e buscando entender e incorporar à sua rotina de trabalho os conceitos de saúde e doença; e ampliar a compreensão de políticas públicas que norteiam a assistência à saúde da população, de organização de sistemas interprofissionais, de serviços e de outros aspectos que possam agregar positivamente ao cuidado em saúde para fortalecer o SUS (COUTINHO, 2011).

Ademais, Oliveira e Wachs (2019) discutiram a organização dos processos de trabalho do PEF na APS, por meio de um estudo aplicado, em que foram ouvidos os profissionais em campo e apontadas atitudes importantes a serem incorporadas à rotina de trabalho da APS, ou seja:

- Ser um profissional proativo para aprender.
- Promover a clínica ampliada.
- Conhecer a rede.
- Reorganizar o cuidado em saúde.
- Participar dos espaços políticos.

**SAIBA MAIS!**

A pesquisa de Oliveira e Wachs (2019) está descrita aqui. Clique para acessar.



Na **Figura 22** são descritas as especificidades necessárias para consolidar as competências do PEF na APS de acordo com o organograma apresentado por Coutinho (2011), que explica as competências dos PEFs na APS conforme as dimensões de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHA), elaboradas por um grupo de profissionais de seis diferentes cidades brasileiras.

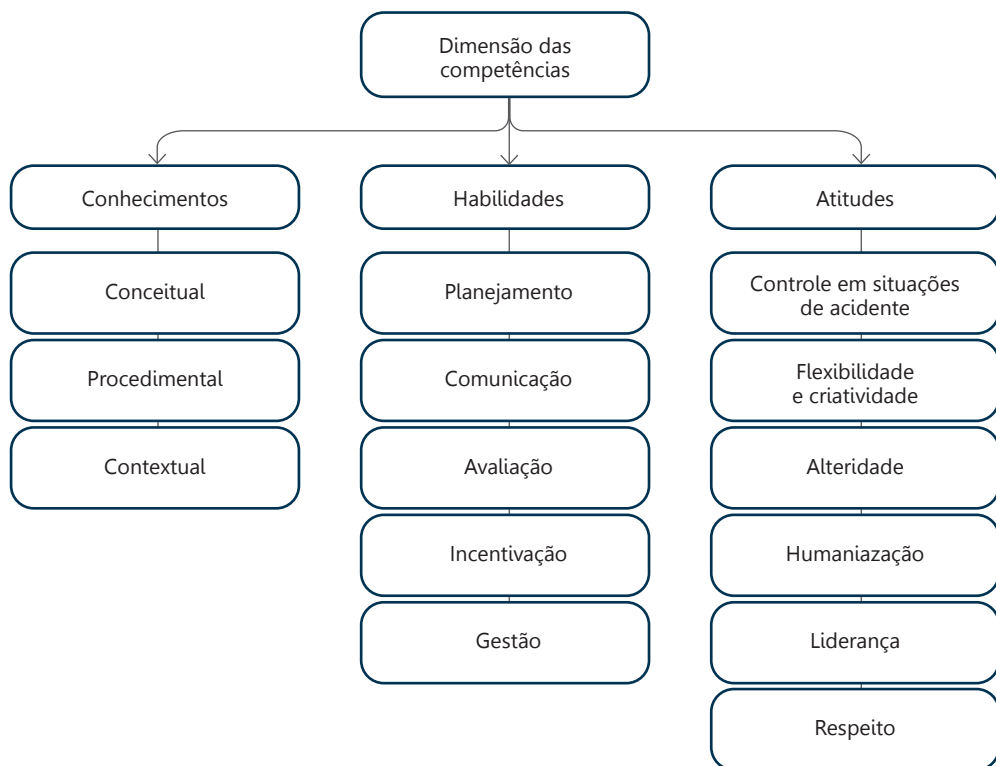


Figura 22: Organograma das dimensões das competências do PEF na APS e seus indicadores.

Fonte: Adaptada de Coutinho, 2011.

1. Conhecimentos

1.1. Conhecimento conceitual

Nesta competência são explorados e dominados os conceitos de teorias envolvidas nos conteúdos teóricos trabalhados desde o curso de graduação (**Quadro 22**).

1.2. Conhecimento procedimental

Neste contexto são abordados pontos importantes quanto às estratégias que tornam possível a compreensão desses conteúdos pela população-alvo e norteiam o profissional para alcançar os objetivos traçados de acordo com a sua função (**Quadro 23**).

Quadro 22: Conhecimentos conceituais para o PEF que atua na APS

Conceito	Observação
Dominar conteúdos biológicos, biomecânicos, psicomotores e dos princípios de treinamento desportivo.	Pressupõe o que acontece no corpo humano quando submetido à prática de exercício físico.
Compreender movimento humano com foco em capacidades físicas e gasto energético.	Pressupõe o que acontece no corpo humano quando submetido à prática de exercício físico.
Ter conhecimento ampliado sobre o corpo no contexto de comunidades e sua relação com o processo de adoecimento não limitado à função biológica.	Permite a discussão de saúde para além dos aspectos biológicos, ou seja, ausência da doença.
Dominar conhecimentos sobre diferenças na prescrição de exercícios para prevenção e promoção da saúde em grupos específicos.	Constituem demanda importante da APS. Ex.: idosos, hipertensos, cardiopatas, portadores de síndromes e outros.

Fonte: Adaptado de Coutinho, 2011.

Quadro 23: Conhecimentos procedimentais para o PEF que atua na APS

Procedimento	Observação
Dominar conhecimentos teóricos e técnicos sobre as especificidades e necessidades de cada população a ser trabalhada para explicar como se faz, o que se faz e porque se faz.	Desperta para a necessidade de domínio metodológico para atingir um objetivo.
Dominar conhecimentos e os objetivos das medidas e avaliação baseados em evidências e parâmetros concretos.	Utilizado para conhecer melhor as condições de saúde das populações-alvo na APS e verificar a efetividade de ações de promoção da saúde baseadas em atividade física.
Dominar os protocolos de avaliação dos pontos de vista práticos com coerência para o público-alvo aplicado.	Utilizado para conhecer melhor as condições de saúde das populações-alvo na APS e verificar a efetividade de ações de promoção da saúde baseadas em atividade física.
Dominar o conceito de práticas corporais baseado em cultura corporal do movimento: jogos, dança, esportes, lutas, ginástica, jogos de salão e práticas rotineiras e esporádicas, como caminhada e escalada, respectivamente.	O espaço da APS requer possibilidades e abordagens que deem a possibilidade de o indivíduo se identificar com algumas práticas corporais, além das tradicionais.

Fonte: Adaptado de Coutinho, 2011.

1.3. Conhecimento contextual

Esta vertente do conhecimento tem como objetivo fazer que o profissional se situe e conheça as características do ambiente onde trabalha – dominando a estrutura e funcionamento do sistema público – e se inteire do conhecimento dos indiví-

duos com quem atua e que vão receber os conhecimentos e orientações que ele vai lhes ministrar (**Quadro 24**).

Quadro 24: Conhecimentos contextuais para o PEF que atua na APS

Contexto	Observação
Dominar conhecimentos sobre o SUS, seu processo de construção e consolidação, seus princípios, diretrizes e organização de atenção e gestão.	Destaca a necessidade de se conhecer além da atividade física em si, para que as intervenções propostas sejam norteadas pela estrutura proposta pelo sistema público de saúde.
Dominar conhecimentos específicos sobre a rede do SUS: Serviços, direitos, deveres, área de atuação, limites, responsabilidades e possibilidades.	Conhecer quais serviços são ofertados pelo município, na sua área de abrangência, e a população destinada.
Conhecer as políticas públicas nacionais, estaduais e municipais que regulamentam a atuação da Educação Física no SUS e na APS.	Conhecer a Política Nacional de Promoção da Saúde e a priorização dos sete eixos temáticos, entre eles o eixo denominado Práticas Corporais e Atividade Física.
Dominar o conhecimento sobre a forma e captação de recursos, apresentação de projetos, as instâncias responsáveis e o fluxo hierárquico a ser seguido.	Como parte importante do apoio matricial está o desenvolvimento de ações e projetos de captação de recursos para o apoio à prática de atividade física e à sua promoção.
Dominar o conhecimento de singularidades, desejos e prazeres do ser humano que se relacionam com as práticas corporais bem estruturadas.	Nesta competência estão pautados a priorização do autoconhecimento, o autocuidado, o sensível, o expressivo e o criativo, para aspectos de atividade física pautados em prevenção e criação.
Dominar conhecimentos pelos quais as práticas corporais são realizadas em determinada comunidade, mapeando os locais onde estas acontecem.	Respeita a pluralidade cultural e agrega valores a essa comunidade e cultura.
Dominar conhecimentos sobre epidemiologia que norteiam as necessidades e determinantes sociais de saúde das pessoas em território de desenvolvimento das atividades.	Pauta-se nos conhecimentos do perfil populacional que será beneficiado com as propostas de atividade física e práticas corporais.
Dominar conhecimentos para discutir a corporeidade e o lazer no âmbito da APS.	Respeita a singularidade das pessoas e as diversidades das práticas corporais.

2. Habilidades

As competências relacionadas às habilidades revelam a capacidade que o PEF precisa desenvolver e aprimorar para executar alguma tarefa ou ação. Segundo Coutinho (2011), existem cinco dimensões de habilidades que são possíveis de serem

desenvolvidas em um PEF que atua na APS: Planejamento, Comunicação, Avaliação, Incentivação e Gestão.

As dimensões das habilidades e suas especificidades estão descritas no **Quadro 25**.

Quadro 25: Dimensões das habilidades com suas especificidades nos nichos de: Planejamento, Comunicação, Avaliação, Incentivação e Gestão

Dimensão do planejamento
Capacidade de planejar ações relacionadas às demandas oriundas do local de atuação.
Estabelecer métodos, cumprir programações, organizar e estruturar a atuação profissional com base em aspectos multidisciplinares.
Utilizar uma lógica racional para implantação e implementação da prática laboral.
Desenvolver estratégias e metodologias de formação.
Ser capaz de capacitar profissionais e, ou, membros da comunidade para atuarem como facilitadores nas ações de atividade física.
Apoiar e instrumentalizar, de forma matriarcal, outros profissionais de saúde para o entendimento básico de atividades corporais.
Buscar a atualização e capacitação profissional constantemente e sempre que necessário.
Realizar ações de prevenção, baseando-se na agenda de saúde pública.
Construir ações em saúde de forma coletiva.
Ter a capacidade de diversificar as práticas corporais, evitando a monotonia e programas de atividades prontas. Propor prazer e lúdico e quebrar padrões.
Ser capaz de manipular variáveis, como intensidade, volume, frequência, ritmo, modalidade, público-alvo, local, respostas fisiológicas e contraindicações.
Ser capaz de prescrever exercícios físicos para grupos especiais, a fim de melhorar uma condição específica de saúde, controlando fatores de risco.
Organizar eventos que promovam as práticas corporais de saúde para atingir grandes públicos.
Elaborar e criar programas e projetos de longo prazo e em larga escala populacional.
Dimensão da comunicação
Ser capaz de estabelecer vínculo com os usuários e com a comunidade.
Ser capaz de fazer o usuário compreender as adaptações fisiológicas que acontecem no seu organismo, por meio da atividade física.
Esclarecer sobre cuidados gerais na manutenção da saúde, mobilidade funcional, socialização e lazer.
Conscientizar sobre a importância da regularidade na prática de atividade física.
Instruir e abordar em suas recomendações aspectos como: sono, álcool, tabagismo, nutrição, descanso, lazer, hidratação e outros.
Ter a capacidade de multiplicar ações para mudança de hábitos.
Buscar a autonomia do usuário para a prática de atividade física.

continua...

...continuação

Dimensão da avaliação
Ser capaz de realizar avaliação física antropométrica e cardiovascular, histórico de saúde e histórico psiquiátrico.
Ser capaz de interpretar informações obtidas por essas avaliações.
Avaliar o programa de atividade física e analisar os resultados individuais e coletivos.
Realizar avaliações individuais e coletivas para que as atividades sugeridas se encaixem no contexto cultural e social em que essas pessoas estão inseridas.
Dimensão da incentivação
Favorecer a participação do usuário, por meio da autonomia, do empoderamento e da corresponsabilidade.
Propor atividades que permitam a participação de todos, por meio de cenários acolhedores e respeitosos.
Coordenar atividades que favoreçam a socialização e inclusão.
Dimensão da gestão
Gerir imprevistos nas realidades dos grupos.
Compreender as dificuldades, possibilitando adaptações e ações resolutivas.
Ser capaz de problematizar possibilidades de intervenção na comunidade e com a equipe de Saúde, a fim de aprofundar as discussões sobre as ações em saúde.
Agir priorizando a inclusão e estimulando a participação da comunidade.
Ser capaz de atuar em equipes multi-intertransdisciplinares, considerando a dinâmica de trabalho do SUS.
Compor, mediar, estimular e envolver pessoas.
Compreender, ampliar, direcionar e resolver problemas.
Garantir ao gestor dados coerentes e fidedignos para os projetos se justificarem.
Procurar articulação em Redes de Saúde.
Mapear Redes de Proteção Social.
Prestar primeiros socorros em emergências no decorrer do serviço.

3. Atitudes/Prática

A dimensão atitudinal diz respeito ao comportamento do profissional diante de diferentes situações e ações (**Quadro 26**).

Quadro 26: Atitudes que auxiliam e norteiam o trabalho do PEF na APS

Atitude
Demonstrar controle em uma situação de acidente durante as atividades.
Demonstrar flexibilidade e criatividade diante da complexidade e variabilidade presentes no contexto da APS.
Demonstrar alteridade e capacidade de se colocar no lugar de outros profissionais e de usuários da APS, reconhecendo o papel de cada um no processo de promoção e proteção da saúde.
Demonstrar, por meio de relações humanizadas, o entendimento das diferenças e imperfeições entre indivíduos.
Demonstrar liderança diante das atividades, avaliando ideias, possuindo escuta ativa, dialogando e delegando tarefas.
Ter ações baseadas em respeito às diferenças e mediar conflitos.

Fonte: Coutinho, 2011.

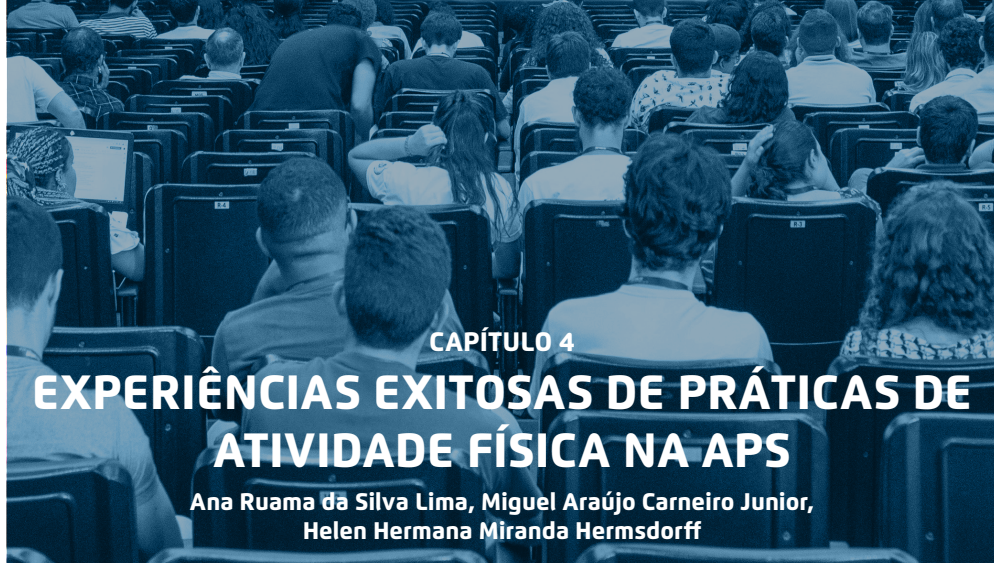


FIQUE LIGADO!

As atitudes adotadas no dia a dia do trabalho precisam ser pautadas em termos éticos e de habilidades pessoais.

REFERÊNCIAS

- BRASIL – Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. **Ferramentas para a gestão e para o trabalho cotidiano Brasília:** Ministério da Saúde, 2014. 116 p.: il. (Cadernos de Atenção Básica, no 39).
- CONFED – Conselho Federal de Educação Física. Profissional de educação física na saúde está na CBO. **Revista Educação Física**, 2020.
- COUTINHO, S. S. **Competências do profissional de Educação Física na Atenção Básica à Saúde**. 2011. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, Ribeirão Preto, SP, 2011.
- OLIVEIRA, B. N.; WACHS, F. Educação Física, atenção primária a saúde e organização do trabalho com apoio matricial. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 41, n. 2, p. 183-89.



CAPÍTULO 4

EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE PRÁTICAS DE ATIVIDADE FÍSICA NA APS

Ana Ruama da Silva Lima, Miguel Araújo Carneiro Junior,
Helen Hermana Miranda Hermsdorff

1. Definição da “Prática Exitosa”

O conceito de **Práticas exitosas em atividade física na APS** está relacionado a um tipo de ação que promove aumento da atividade física dos participantes, por meio de um processo planejado, replicável e sustentável que garante e promove a participação e a autonomia (BENEDETTI et al., 2020).



FIQUE LIGADO!

O conceito apresentado envolve projetos, programas, práticas e qualquer outro tipo de atividade desenvolvida na APS (BRASIL, 2021).

Para que uma prática em atividade física seja considerada exitosa é necessário que ela apresente alguns atributos, como: planejamento, sustentabilidade, replicação, participação e autonomia (BENEDETTI et al., 2020). O **Quadro 27** traz a descrição de cada um desses atributos.



PARA REFLETIR!

Você conhece alguma prática exitosa em atividade física na APS do seu município? Reconhece os atributos citados presentes nessa prática?

Quadro 27: Atributos das práticas exitosas em atividade física na APS

Planejamento
Envolve o planejamento de ações que consideram a realidade local (demandas do território; demandas por serviços; recursos financeiros, humanos e materiais; cultura; e capacidade técnica), que ocorrem de forma colaborativa (entre usuários, profissionais de saúde e gestores), que deixam claro para qual grupo são destinadas e que possuem objetivos tangíveis e metas mensuráveis que precisam ser avaliadas continuamente tanto para a ação quanto para os participantes.
Sustentabilidade
Corresponde a uma ação que é mantida e continuada no local, com potencial para ser institucionalizada e capaz de aumentar a atividade física dos participantes de modo sustentável.
Replicação
Ação descrita com clareza e aplicável a outros locais, desde que seja respeitado cada contexto.
Participação
Ação capaz de promover o engajamento e vínculo dos usuários com o serviço e que haja a adesão e assiduidade dos participantes.
Autonomia
Ação capaz de promover a autonomia dos participantes para o engajamento nas decisões e conhecimentos que possam contribuir para o autocuidado e a corresponsabilidade com a saúde individual.

Fonte: Adaptado de Benedetti et al., 2020, p. 508-9.

Os profissionais de Saúde podem, e devem, identificar quais estratégias podem ser adotadas de acordo com as características de suas ações, visando tornar determinada prática de atividade física em prática exitosa. Entre essas estratégias, é importante que sejam consideradas oito essenciais, as quais são apresentadas na **Figura 23**.

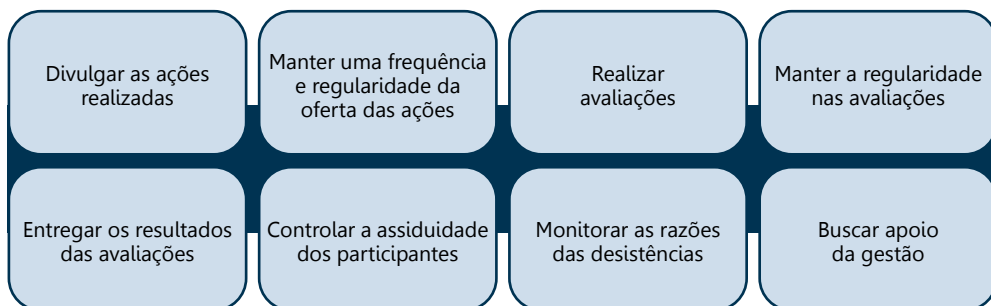


Figura 23: Estratégias essenciais para tornar uma prática de atividade física exitosa.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2021.

**SAIBA MAIS!**

Para saber mais sobre a importância e possibilidades de aplicação das estratégias essenciais, consulte o material **Recomendações para o Desenvolvimento de Práticas Exitosas de Atividade Física na Atenção Primária à Saúde do Sistema Único de Saúde**, clique aqui.



2. Expectativa *versus* evidências/cotidiano

Em estudo desenvolvido por Bonfim et al. (2012), eles buscaram agrupar e analisar os relatos de experiências de programas de atividades físicas desenvolvidos no âmbito da Saúde Pública brasileira, considerando as diretrizes da PNPS (**Quadro 28**).

Quadro 28: Programas de atividades físicas analisados

Programa Academia da Cidade (PE)
Programa CuritibaAtiva
Programa Academia da Cidade (SE)
Programa Caminhando para a Saúde
Programa Agita Lourdes
Programa Saúde Ativa Rio Claro
Projeto Se Bole Olinda
Programa Agita São Paulo
Programa Comunitário de Atividade Física
Programa Saúde em Movimento
Projeto Saúde na Praça

Fonte: Adaptado de Bonfim et al., 2012, p. 169.

A partir de seus estudos, Bonfim et al. (2012) verificaram que as experiências apresentadas no **Quadro 28** foram, em sua maioria, efetivadas antes da aprovação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), com exceção do Programa “Se Bole Olinda”, em que, talvez por isso, suas atividades desenvolvidas nem sempre eram condizentes com as orientações preconizadas pela PNPS. Dessa forma, esses autores confrontam algumas ações com as orientações dispostas pela PNPS (**Quadro 29**).

Quadro 29: Orientações PNPS x Realidade prática

Orientação PNPS	Realidade prática
As ações devem contemplar a oferta de práticas corporais/atividade física voltadas tanto para a comunidade como um todo quanto para grupos vulneráveis, além de “capacitem os trabalhadores de saúde”.	Tendência à implantação de programas na tentativa de diminuir as DCNT, correndo-se o risco de priorizar somente a doença e, ao mesmo tempo, ignorar o próprio sujeito.
Necessidade de incentivar articulações inter-setoriais para a melhoria das condições dos espaços públicos, para a realização de práticas corporais/atividades físicas.	Poucos programas inserem essas ações em suas atividades, bem como realizam parcerias com órgãos municipais pertinentes.
As ações de monitoramento e avaliação visam desenvolver estudos e formular metodologias capazes de produzir evidências e comprovar a efetividade de estratégias de práticas corporais/atividades físicas no controle e prevenção das DCNT.	Observa-se nos programas uma diversidade muito grande de instrumentos avaliativos, o que acaba limitando os processos de avaliação de sua efetividade.

Fonte: Adaptado de Bonfim et al., 2012.

Assim, conclui-se que, até a ocasião da publicação do estudo em questão, as ações dos programas não contemplavam, em sua grande parte, os princípios norteadores da PNPS, apontando para a necessidade de adequação dos programas já instituídos naquela época.

3. Na prática: experiências de sucesso

O conteúdo abordado neste tópico apresenta algumas experiências de práticas exitosas em atividade física no contexto da APS.

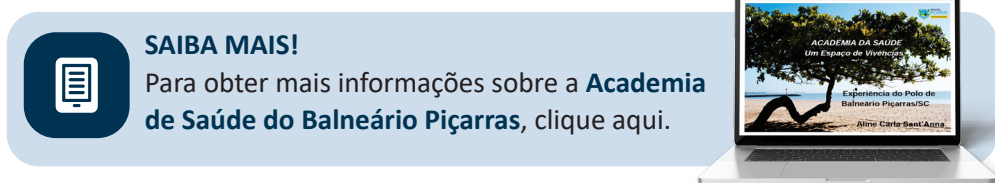
- **Academia de Saúde Balneário Piçarras:** A experiência que teve início desde o ano 2007 na pequena cidade de Balneário Piçarras, no litoral norte de Santa Catarina, hoje é destaque em níveis estadual e nacional, no que diz respeito à promoção da saúde por meio de práticas corporais/atividade física (GOVERNO DE SANTA CATARINA, 2017). Atualmente, esse programa conta com dois polos da Academia da Saúde, em que o polo centro conta com um local de 135 m², que contém sala de espera, tatame, espelho, mesa para avaliação e material esportivo (colchonetes, cordas, halteres, caneleiras, bastões, bolas, entre outros), atendendo crianças, jovens, adultos e idosos. A divulgação des-

se polo ocorre via jornais, rádios locais, outdoors, cartazes, pôsteres, agentes comunitários de Saúde, Rede de Atenção da Saúde do município e redes sociais (SOUZA, s.d.; SANT'ANNA, s.d.). As atividades voltadas para as práticas corporais/atividade física desenvolvidas no programa são apresentadas na **Figura 24**.

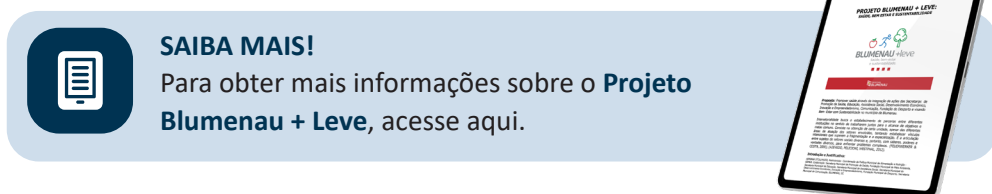


Figura 24: Práticas corporais/atividade física desenvolvidas na Academia de Saúde Balneário Piçarras.

Fonte: Adaptado de Sant'anna (s.d).



- **Projeto Blumenau + Leve:** saúde, bem-estar e sustentabilidade – Criado no ano 2017, o Projeto Blumenau + Leve surgiu com a proposta de promover saúde e bem-estar com sustentabilidade, por meio da integração de ações de vários setores do município de Blumenau-SC, contemplando desde recém-nascidos até o público idoso (STOLLMAIER, s.d.). Os setores envolvidos neste projeto e em suas correspondentes ações relativas às práticas corporais/atividade física são apresentados no **Quadro 30**.



Quadro 30: Setores envolvidos no Projeto Blumenau + Leve e suas correspondentes ações relativas às práticas corporais/atividade física

Setor	Ação
Secretaria Municipal de Promoção de Saúde (SEMUS)	Promoção da Saúde – Ações nos diversos serviços, abrangendo grupos de educação em saúde com temas relacionados a hipertensão arterial, <i>Diabetes Mellitus</i>, alimentação saudável e controle de peso; práticas integrativas e complementares (práticas corporais e mentais da medicina tradicional chinesa), entre outros. Pessoa com Deficiência – Intervir em pessoas com deficiência, no que diz respeito às questões relacionadas ao peso, à alimentação e à atividade física.
Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM)	Criação de conceitos de peças gráficas; divulgação das ações e eventos; e incentivo à participação popular.
Fundação Municipal do Desporto (FMD)	Ações nas diversas modalidades esportivas (atletismo, artes marciais, basquete, voleibol), da base ao alto rendimento.
Secretaria Municipal de Educação (SEMED)	Programa de Saúde na Escola – Avaliação e atenção integral à saúde do escolar do município de Blumenau. Projeto Linguagem do Movimento – Visa estimular a participação das crianças para a prática do movimento corporal em suas mais variadas formas. Projeto Forças no Esporte (PROFESP) – Observam-se os princípios gerais aplicados aos programas e projetos de natureza esportiva com enfoque social, acrescentando-se a eles um novo conceito, que propicia uma forma de direcionamento das relações entre os segmentos componentes do esporte, da atividade física e do lazer. Programa Paradesporto Escolar – Tem como objetivos fomentar, difundir e realizar a prática da atividade física para crianças, adolescentes e jovens com deficiência e síndromes de toda a Rede de Ensino de Blumenau, seja municipal, estadual e particular, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Fonte: Adaptado de Stollmaier, s.d.

A possibilidade de identificar experiências de práticas exitosas em atividade física no contexto da APS já efetivadas no Brasil permite verificar que, por meio do planejamento da prática guiada por recomendações efetivas, é possível obter êxito em estratégias que, além de contribuírem para qualificar a atuação do profissional, beneficia a população, trazendo, assim, resultados positivos à saúde (BRASIL, 2021).

REFERÊNCIAS

- BENEDETTI, T. R. B. et al. Práticas exitosas em atividade física na Atenção Primária à Saúde: elaboração do conceito. **Saúde e Pesquisa**, v. 13, n. 3, p. 503-13, Maringá, PR, 2020.
- BONFIM, M. R. et al. Ações de Educação Física na Saúde Coletiva Brasileira: expectativas versus evidências. **Rev. Bras. Ativ. e Saúde**, v. 17, n. 13, p. 167-73, Pelotas, RS, 2012.
- BRASIL – Ministério da Saúde. **Recomendações para o desenvolvimento de práticas exitosas de atividade física na Atenção Primária à Saúde do Sistema Único de Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.
- DE SOUZA, T. V. **Academia da Saúde Balneário Piçarras**. [S.l. : s.n.t.], [s.d.]. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/academia_da_saude_balneario_picarras.pdf.
- GOVERNO DE SANTA CATARINA. **A Academia da Saúde de Balneário Piçarras é destaque estadual e nacional**. Piçarras, SC, 2017. Disponível em: https://www.saude.sc.gov.br/?option=com_content&view=article&id=5697:academia-a-saude-de-balneario-picarras-e-destaque-estadual-e-nacional&catid=1417:ascom-assessoria-de-comunicacao-2017.
- SANT'ANNA, A. C. **Academia da Saúde um espaço de vivências**: experiência do polo de Balneário Piçarras/SC. Piçarras, SC: [s.n.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.saude.sc.gov.br/index.php/informacoes-gerais-documentos/atencao-basica/nucleos/nucleo-de-atencao-as-pessoas-com-doencas-cronicas/academia-da-saude/seminario-academia-da-saude-2015/10068-um-espaco-de-vivencias-balneario-picarras/file>.
- STOLLMAIER, A. **Projeto Blumenau + Leve**: saúde, bem-estar e sustentabilidade. [S.l. : s.n.t.], [s.d.]. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/blumenau_mais_leve_saude_bemestar_sustenta.pdf.
- STOLLMAIER, A. **Relato Blumenau + Leve**. [S.l. : s.n.t.], [s.d.]. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/relato_projeto_blumenau_mais_leve.pdf.

O Brasil, nas últimas décadas, tem vivenciado um avanço muito rápido no número de pessoas com excesso de peso ou obesidade, além de outras doenças crônicas como dislipidemias, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. A Atenção Primária à Saúde é um espaço fundamental para a prevenção e o cuidado integral de pessoas nessa condição de saúde. Desse modo, quando ampliamos a capacidade de gestão dos estados e dos municípios, bem como a organização no processo de trabalho, os resultados relativos ao manejo dessas doenças no âmbito do Sistema Único de Saúde são mais efetivos.

Nesse contexto, o projeto Rede para enfrentamento da obesidade e doenças crônicas em Minas Gerais (RENOB-MG) tem como objetivo propiciar a construção de uma rede organizada e qualificada para a atenção à saúde, bem como a excelência em gestão para o gerenciamento dessas condições em Minas Gerais, a partir de ações de diagnóstico, formação, gestão, avaliação e monitoramento – envolvendo atividades de pesquisa, ensino e extensão.

Para tanto, nossa equipe elaborou duas coleções de livros digitais – Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para gestores de saúde e Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para profissionais de saúde – para capacitar, consolidar e enriquecer o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde e gestores da Atenção Primária à Saúde no cuidado da obesidade e no cuidado integral da pessoa que vive com essa e outras doenças crônicas, tais como diabetes e hipertensão arterial sistêmica.



UFV
Universidade Federal
de Viçosa



IPPDS
Instituto de Políticas Públicas e
Desenvolvimento Sustentável